3 La spesa sanitaria e i costi dei servizi: composizione ed evoluzione nella prospettiva nazionale, regionale ed aziendale

di Alessandro Furnari, Elisabetta Notarnicola, Giordana Puritani, Alberto Ricci e Silvia Rota[1]

3.1 Introduzione

Il capitolo illustra i dati di spesa, finanziamento e performance economica del SSN italiano, integrandoli con un confronto internazionale. L'intento del Capitolo è di illustrare le dinamiche e i trend evolutivi della spesa sanitaria e del relativo finanziamento, articolati in tre livelli di rappresentazione per apprezzare le dinamiche tra il livello nazionale, regionale e aziendale. Il primo livello di presentazione e commento ai dati è relativo all'andamento macroeconomico della spesa sanitaria, inteso come confronto tra l'entità della spesa in rapporto al PIL (oltre ad altre misure) del nostro Paese con quella di altri contesti internazionali, per discutere del posizionamento delle politiche pubbliche italiane e degli (eventuali) spazi di manovra esistenti. L'attenzione si concentra poi sull'analisi della composizione della spesa sanitaria a livello nazionale, osservando la dinamica e il ruolo delle diverse componenti della spesa. L'ultimo livello di rappresentazione è dato dalle performance economiche di Regioni e Aziende, con un approfondimento sull'andamento dei principali fattori produttivi e delle diverse strategie immaginate o attivate per fronteggiare la loro evoluzione. Nello specifico, vengono approfondite nove realtà regionali e quindici realtà aziendali.

Queste differenti prospettive consentono di apprezzare il diverso contributo offerto dalle dimensioni finanziaria ed economica sul SSN, sui SSR e sulle

[1] Sebbene il paragrafo sia frutto del lavoro congiunto degli autori il paragrafo 3.1 è attribuibile ad Alessandro Furnari ed Elisabetta Notarnicola, i paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 a Giordana Puritani, il paragrafo 3.5 ad Alessandro Furnari e Silvia Rota, il paragrafo 3.6 ad Alberto Ricci, il paragrafo 3.7 a tutti gli autori. Le autrici e gli autori ringraziano il Dottor Alessandro Comin che ha collaborato al presente lavoro di ricerca, contribuendo alla raccolta dei dati e delle informazioni. Gli autori desiderano ringraziare l'Ufficio IV - Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute per i dati e il supporto fornito.

aziende: quella finanziaria in quanto espressione delle decisioni programmatiche e redistributiva delle risorse (e di come queste si modificano nel tempo), nonché della capacità far fronte alle obbligazioni assunte; quella economica in quanto consente di apprezzare una rappresentazione completa delle attività aziendali e di tener conto delle combinazioni economiche e della loro produttività ed efficienza.

Sotto il profilo dell'analisi, il capitolo presenta i dati di confronto internazionale fino al 2023, ultimo anno disponibile sulla fonte di dati utilizzata (OECD Health Statistics). Si rimanda agli approfondimenti presentati nel capitolo 3 del Rapporto OASI 2018 (Armeni *et al.*, 2018) per un approfondimento sulla metodologia impiegata. A livello nazionale, il capitolo presenta invece i dati 2024 a confronto con gli anni precedenti, soprattutto il periodo 2019-2023. La fonte dei dati di spesa sanitaria pubblica nazionale utilizzata nel presente capitolo è il Ministero della Salute, mentre le altre grandezze utilizzate provengono da fonte ISTAT (popolazione e PIL). Per un quadro completo delle relazioni tra i diversi dati di spesa sanitaria italiana, si rimanda in questo caso all'allegato del Capitolo 3 del Rapporto OASI 2009 (Armeni, 2009). Infine, le fonti utilizzate per l'analisi delle performance economiche sui livelli regionali e aziendali sono i Conti Economici di Regioni e Aziende del SSN per il periodo 2019-2024, forniti dal Ministero della Salute e dalle Aziende stesse. In questo caso, si rimanda ai §§ 3.5 e 3.6 per una descrizione dettagliata dell'approccio metodologico impiegato.

Il capitolo è così strutturato: nel §3.2 si analizzano i dati di spesa sanitaria dei principali Paesi Europei (Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito) e degli Stati Uniti; nel §3.3 sono riportati e commentati i dati relativi al finanziamento del SSN (assegnazioni e risorse complessivamente disponibili[2]) e alla spesa sanitaria corrente pubblica e privata a livello nazionale. Il §3.4 è invece dedicato al dettaglio dei dati di spesa, con un'analisi dell'evoluzione della performance finanziaria a livello regionale. Nel §3.5 si descrivono i nove casi studio regionali sopra-citati, adottando in questo caso la prospettiva della competenza economica e proponendo una riclassificazione delle risorse gestite e assorbite dalle regioni del campione. Il §3.6 introduce la prospettiva aziendale e propone un'analisi sulle principali aziende ospedaliere pubbliche del Paese. Infine, il §3.7 delinea le conclusioni a fronte delle analisi condotte nei paragrafi precedenti.

[2] Le risorse complessivamente disponibili sono equivalenti alla voce denominata "Ricavi del SSN" come definito dal Ministero della Salute, si veda sotto per i dettagli.

3.2 La spesa sanitaria: un confronto internazionale

La spesa sanitaria nei sei Paesi considerati (Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) riflette l'eterogeneità degli assetti istituzionali e si caratterizza per livelli, composizioni e dinamiche altamente differenziate. I dati presentati (fino al 2023, ultimo anno disponibile), mostrano inoltre come la pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto significativo sulle dinamiche di spesa in tutti i contesti osservati.

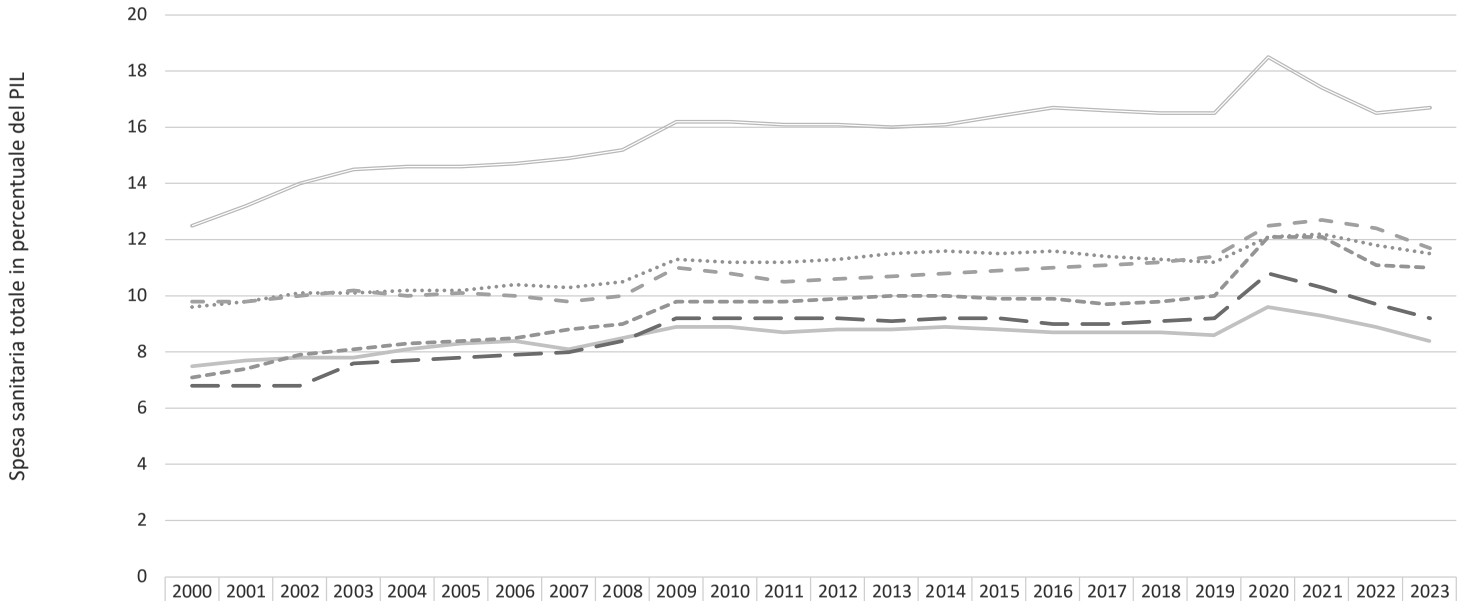
La spesa sanitaria espressa come percentuale del PIL (Figura 3.1) indica la quota dell'economia di un Paese relativa ai servizi sanitari, ovvero la proporzione della spesa complessiva destinata a tali servizi[3]. Tale indicatore fornisce una misura del grado di rilevanza economica del sistema sanitario rispetto al macro-sistema produttivo di un Paese, inteso come somma dei redditi di tutte le famiglie e di tutte le imprese. È importante sottolineare che, a parità di peso sul PIL, due Paesi possono mostrare livelli di accesso complessivo, di equità di accesso nella popolazione e di sostenibilità diversi a causa di differenze nei prezzi. È il caso degli Stati Uniti, sistema più vicino alle logiche di mercato e con prezzi poco regolati. Nonostante presenti un'incidenza della spesa sanitaria sul PIL pari al 16,7% nel 2023 (dato più alto in assoluto), registra livelli di equità nell'accesso ai servizi inferiori a Paesi come Italia o Francia, che proporzionalmente hanno una spesa più ridotta (van Doorslaer *et al.*, 2004). Inoltre, sistemi diversamente strutturati hanno costi di funzionamento potenzialmente differenti.

In Italia, la spesa sanitaria complessiva sul PIL mostra un'incidenza del 8,4% nel 2023, inferiore rispetto agli altri Paesi considerati, a conferma del trend osservato negli ultimi anni (Figura 3.1). Seppur non mostrato in figura, è importante sottolineare come la stessa evidenza si rilevi anche considerando un sottoinsieme della spesa sanitaria complessiva, cioè la spesa sanitaria pubblica o per schemi assicurativi obbligatori in percentuale del PIL: nel 2023, per l'Italia il rapporto è pari al 6,1%, il più basso tra tutti i Paesi considerati (Spagna: 6,7%; Regno Unito: 8,9%; Francia: 9,7%; Germania: 10,1%; Stati Uniti: 13,9%).

Considerando la spesa sanitaria totale in percentuale del PIL, tra il 2022 e il 2023, l'Italia ha registrato un decremento di questo indicatore (-0,5%), anche rispetto ai livelli del 2019, l'anno precedente alla pandemia (-0,2%). Anche negli altri Paesi considerati si rileva una diminuzione della spesa sanitaria sul PIL tra il 2022 e il 2023, compresa tra -0,7% (Germania) e -0,1% (Regno Unito). In quasi tutti i Paesi questo calo è trainato da una riduzione della spesa sanitaria pubblica o per schemi assicurativi obbligatori, ed è quindi ascrivibile, almeno

[3] Non si parla di settore sanitario in generale in quanto quest'ultimo comprende anche altri attori, come le imprese fornitrici, la cui dimensione economica non è inclusa in questo indicatore, se non nei limiti delle operazioni di acquisto (cfr. Del Vecchio, 2012).

Figura 3.1 **Spesa sanitaria totale in percentuale del PIL (2000-2023)**



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Francia	9,6	9,8	10,1	10,1	10,2	10,2	10,4	10,3	10,5	11,3	11,2	11,2	11,3	11,5	11,6	11,5	11,6	11,4	11,3	11,2	12,1	12,2	11,8	11,5
Germania	9,8	9,8	10,0	10,2	10,0	10,1	10,0	9,8	10,0	11,0	10,8	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,4	12,5	12,7	12,4	11,7
Italia	7,5	7,7	7,8	7,8	8,1	8,3	8,4	8,1	8,5	8,9	8,9	8,7	8,8	8,8	8,9	8,8	8,7	8,7	8,7	8,6	9,6	9,3	8,9	8,4
Spagna	6,8	6,8	6,8	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,4	9,2	9,2	9,2	9,2	9,1	9,2	9,2	9,0	9,0	9,1	9,2	10,8	10,3	9,7	9,2
Regno Unito	7,1	7,4	7,9	8,1	8,3	8,4	8,5	8,8	9,0	9,8	9,8	9,8	9,9	10,0	10,0	9,9	9,9	9,7	9,8	10,0	12,1	12,1	11,1	11,0
Stati Uniti	12,5	13,2	14,0	14,5	14,6	14,6	14,7	14,9	15,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,0	16,1	16,4	16,7	16,6	16,5	16,5	18,5	17,4	16,5	16,7

Fonte: Elaborazioni su dati OECD Health Statistics 2025.

in parte, alla riduzione delle fonti di finanziamento straordinarie, degli interventi e delle politiche adottate per gestire la pandemia.

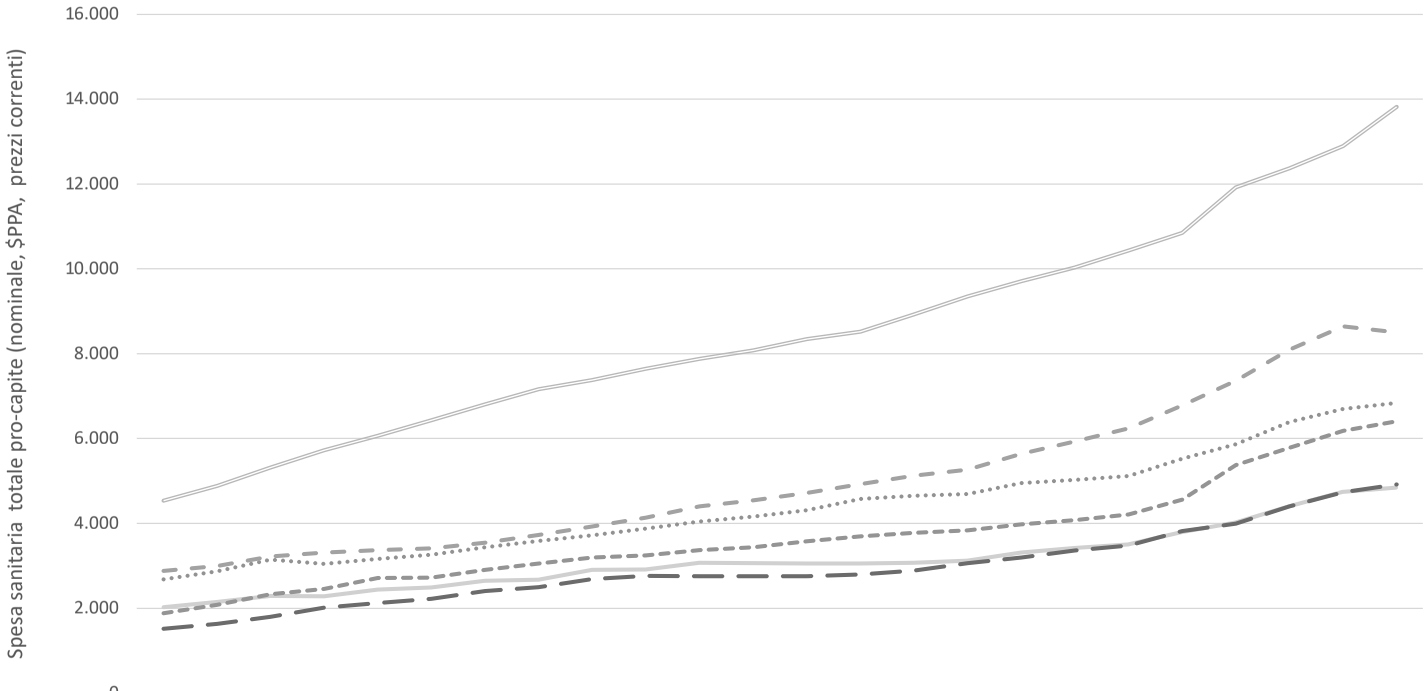
Guardando ai livelli di spesa, il sistema comunemente considerato come quello più vicino al mercato, quello statunitense, presenta, in media, la spesa pro-capite nettamente più elevata (Figura 3.2 e Figura 3.3). Nel 2023, il livello di spesa sanitaria complessiva pro-capite negli Stati Uniti risulta più alto del 119% rispetto alla media dei Paesi europei considerati. In particolare, risulta più alto dell'80% rispetto alla media dei Paesi con assicurazione sanitaria obbligatoria (Francia e Germania) e del 156% rispetto a quella dei Paesi con Servizio Sanitario Nazionale o locale (Italia, Spagna, Regno Unito). È fondamentale, tuttavia, interpretare i livelli di spesa di un Paese in funzione dell'insieme di servizi offerti, della loro organizzazione e gestione, e degli *outcome* di salute raggiunti grazie all'introduzione e diffusione interna dei frutti del progresso scientifico e dell'innovazione tecnologica (*cfr.* Capitolo 7 sugli esiti di salute). Nel 2023, l'Italia presenta il dato di spesa sanitaria nominale pro-capite più basso (Figura 3.2).

Guardando all'evoluzione della spesa (Figura 3.3), si nota come i Paesi si differenzino nettamente per il tasso di crescita della spesa sanitaria nominale pro-capite. Tra il 2010 e il 2023, il tasso di crescita superiore è stato registrato dalla Germania (+93%), seguita da Regno Unito (+90%), Spagna (+78%), Stati Uniti (75%) e Francia (+69%). L'Italia è il Paese che ha registrato il tasso di crescita meno sostenuto (+59%) e nettamente inferiore rispetto agli altri Paesi considerati.

Un elemento importante da considerare nel confrontare la spesa sanitaria di diversi Paesi è la sua composizione[4] rispetto ai soggetti pagatori. Essendo

[4] La proporzione tra il contributo dei tre pagatori (settore pubblico, assicurazioni e cittadini-pazienti) può essere letta come una misura di equità del sistema sanitario. Più è elevata la copertura pubblica, infatti, più il sistema è caratterizzato da equità rispetto al reddito. Infatti, una quota di spesa pubblica elevata corrisponde ad una forte azione di redistribuzione della ricchezza, contribuendo a rendere il sistema più equo nell'accesso alle prestazioni. La componente privata di spesa sanitaria è, invece, maggiormente legata alla capacità di reddito degli individui. In particolare, un sistema incentrato sulla spesa privata assicurativa pone barriere all'accesso a coloro che non possono acquistare una copertura e che non rientrano nei programmi pubblici o a coloro ai quali il datore di lavoro non offre coperture assicurative sanitarie. Inoltre, un'importante barriera all'accesso è costituita da fattori culturali e di percezioni imperfette circa l'effettiva estensione della copertura pubblica, che possono rallentare la diffusione di forme assicurative complementari. Più critica è la componente out-of-pocket, in quanto si tratta di spesa direttamente sostenuta dai pazienti al momento della fruizione dei servizi e, teoricamente, almeno in parte prevenibile tramite sistemi assicurativi. Questa componente non solo crea la percezione di barriere all'accesso, ma è anche regressiva rispetto al reddito. In questa categoria, infatti, ricade anche la spesa di coloro che non hanno potuto o voluto accedere a coperture assicurative private. Tale componente, più legata al reddito che alle politiche sanitarie pubbliche, è un importante oggetto di studio (cfr. capitolo 6) in quanto presenta dinamiche proprie e non banalizzabili con una semplice lettura "per differenza" rispetto alla copertura pubblica.

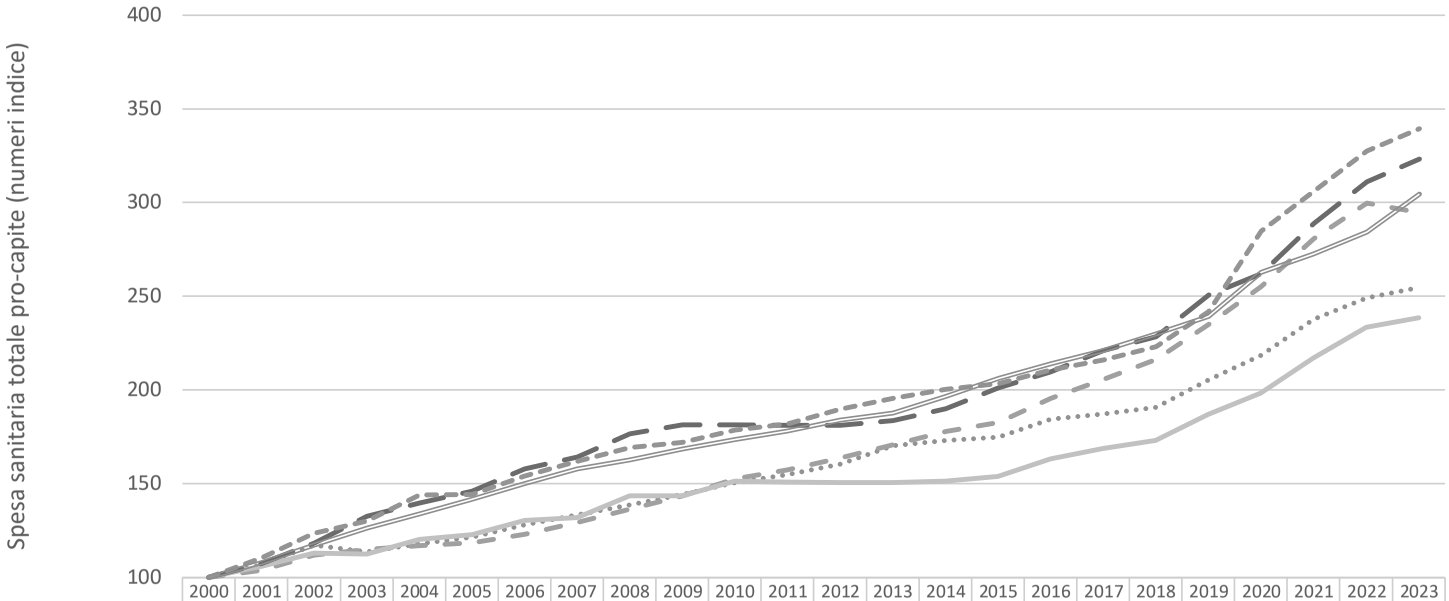
Figura 3.2 **Spesa sanitaria in termini nominali totale pro-capite in $PPA e a prezzi correnti (2000-2023)**



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Francia	2.688	2.876	3.152	3.056	3.171	3.265	3.443	3.588	3.729	3.881	4.047	4.166	4.314	4.581	4.653	4.699	4.959	5.034	5.126	5.526	5.874	6.395	6.701	6.848
Germania	2.886	2.999	3.227	3.315	3.379	3.417	3.549	3.733	3.936	4.141	4.405	4.547	4.725	4.933	5.132	5.276	5.646	5.940	6.247	6.785	7.364	8.103	8.652	8.503
Italia	2.031	2.152	2.291	2.286	2.445	2.496	2.650	2.681	2.913	2.915	3.077	3.065	3.059	3.060	3.073	3.126	3.318	3.427	3.513	3.798	4.027	4.409	4.744	4.847
Spagna	1.524	1.636	1.804	2.024	2.132	2.228	2.409	2.503	2.694	2.767	2.764	2.761	2.760	2.801	2.897	3.065	3.198	3.370	3.481	3.822	3.996	4.405	4.744	4.927
Regno Unito	1.889	2.087	2.337	2.459	2.723	2.727	2.912	3.062	3.201	3.253	3.378	3.439	3.584	3.697	3.787	3.843	3.984	4.084	4.215	4.569	5.381	5.785	6.188	6.412
Stati Uniti	4.538	4.890	5.318	5.728	6.071	6.433	6.810	7.168	7.386	7.646	7.880	8.081	8.348	8.520	8.927	9.355	9.716	10.037	10.436	10.854	11.926	12.375	12.898	13.818

Fonte: Elaborazioni su dati OECD Health Statistics 2025.

Figura 3.3 **Evoluzione spesa sanitaria in termini nominali totale pro-capite in $PPA e a prezzi correnti (2000-2023), numeri indice: 2000=100**



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Francia	100	107	117	114	118	121	128	133	139	144	151	155	160	170	173	175	184	187	191	206	219	238	249	255
Germania	100	104	112	115	117	118	123	129	136	143	153	158	164	171	178	183	196	206	216	235	255	281	300	295
Italia	100	106	113	113	120	123	130	132	143	144	151	151	151	151	151	154	163	169	173	187	198	217	234	239
Spagna	100	107	118	133	140	146	158	164	177	181	181	181	181	184	190	201	210	221	228	251	262	289	311	323
Regno Unito	100	110	124	130	144	144	154	162	169	172	179	182	190	196	200	203	211	216	223	242	285	306	327	339
Stati Uniti	100	108	117	126	134	142	150	158	163	169	174	178	184	188	197	206	214	221	230	239	263	273	284	305

Fonte: Elaborazioni su dati OECD Health Statistics 2025.

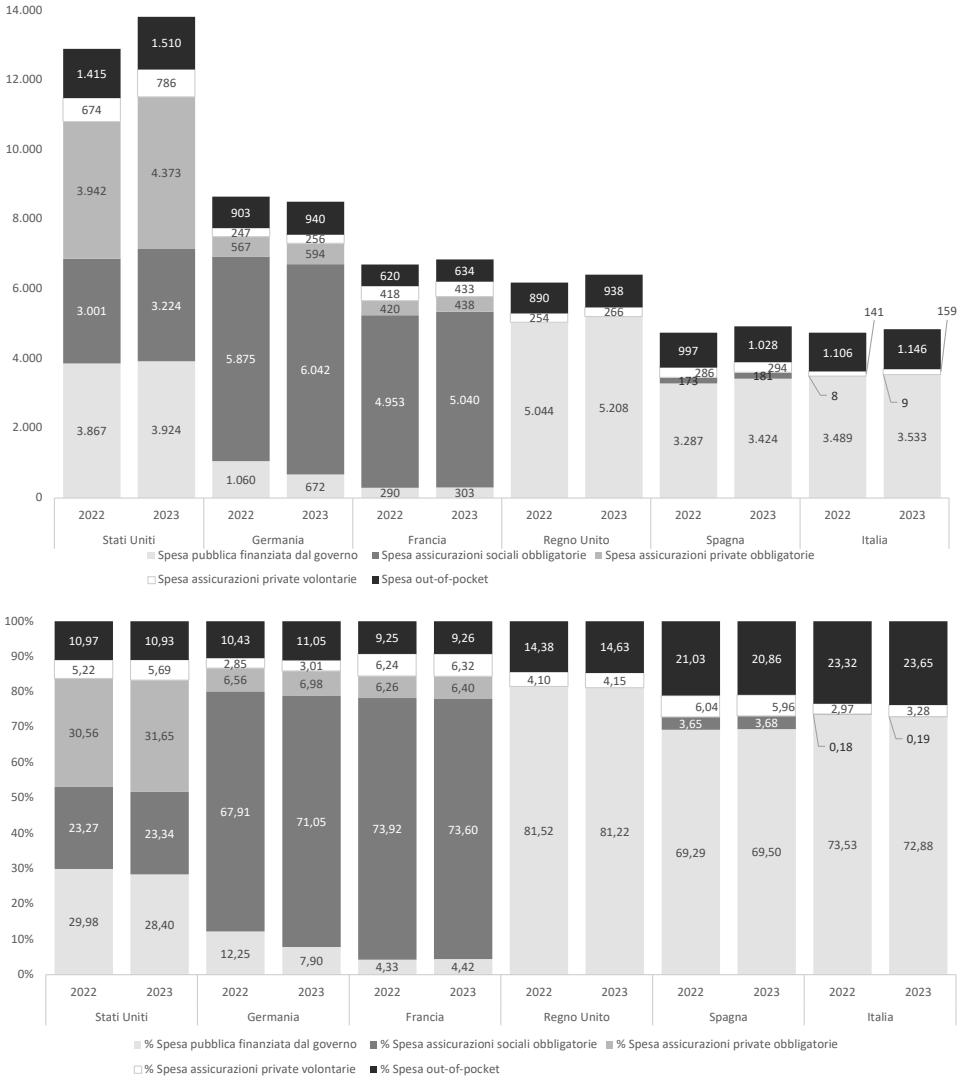
un settore cruciale in ogni Paese, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico, la sanità si caratterizza ovunque per una forte presenza del settore pubblico, sebbene con obiettivi ed estensione variabili in funzione del modello di welfare implementato. Di conseguenza il ruolo degli altri soggetti pagatori (assicurazioni e cittadini-pazienti) è differenziato.

La Figura 3.4 mostra la composizione della spesa sanitaria pro-capite negli ultimi due anni di rilevazione disponibili (2022 e 2023), sia in termini assoluti sia in termini percentuali. Guardando alla distribuzione in termini percentuali, la componente pubblica e assicurativa obbligatoria (sociale e privata) prevista *ex-lege* è molto elevata e prevalente in tutti i Paesi, compresa nel 2023 tra il 73,1% (Italia) e l'85,9% (Germania). È importante sottolineare, tuttavia, come i valori assoluti pro-capite siano estremamente eterogenei tra i Paesi, con stime che vanno da $3.542 in Italia a $11.521 negli Stati Uniti. La componente pubblica e assicurativa obbligatoria ha registrato una diminuzione rispetto 2022 in quasi tutti i Paesi considerati (da -0,09% della Francia a -0,78% della Germania), ad eccezione della Spagna (+0,25%). A seconda degli assetti istituzionali, si rilevano differenze nella distribuzione delle singole voci di spesa: nei Paesi con Servizio Sanitario Nazionale (Italia, Regno Unito e Spagna) la componente più rilevante è rappresentata dalla spesa pubblica finanziata dal governo, mentre nei Paesi con assicurazione sanitaria obbligatoria (Francia e Germania) la componente più rilevante è rappresentata dalla spesa per assicurazioni sociali. Negli Stati Uniti, un'importante voce di spesa è quella relativa alle assicurazioni private obbligatorie, che rappresentano il 31,65% della spesa sanitaria pro-capite nel 2023 (componente molto più ridotta o pressoché nulla nei Paesi Europei).

La parte residua di spesa è coperta dal settore privato nella forma di premi assicurativi volontari, a carico dei cittadini o delle imprese che offrono copertura per i propri dipendenti, oppure di spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai pazienti al momento dell'accesso ai servizi o dell'acquisto di beni. Nella spesa *out-of-pocket* rientrano le prestazioni non coperte da programmi assicurativi pubblici e privati o non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (*out-of-pocket* in senso stretto) e le compartecipazioni per prestazioni solo parzialmente coperte dalla spesa pubblica.

Nel 2023, la componente *out-of-pocket* registra una notevole variabilità tra i Paesi analizzati, dall'9,26% della Francia al 23,65% dell'Italia (Figura 3.4). In termini assoluti, la spesa *out-of-pocket* negli Stati Uniti risulta la più elevata, sia nel 2022 che nel 2023. Il dato italiano suggerisce che circa un quarto della spesa sanitaria nel nostro Paese ricada direttamente sull'individuo nel momento del consumo. È interessante notare come vi sia stata un aumento, seppur molto contenuto, della componente *out-of-pocket* tra il 2022 e il 2023 in Italia (+0,3%), Regno Unito (+0,2%) e Germania (+0,6%). In Spagna tale componente ha visto una lieve diminuzione (-0,2%), mentre negli Stati Uniti e in Francia non ci sono state variazioni.

Figura 3.4 **Composizione della spesa sanitaria pro-capite: finanziata dal governo, per premi assicurativi obbligatori (sociali e privati), per assicurazioni private volontarie e out-of-pocket (2022-2023) in $PPA (sopra) e in % (sotto)**



Fonte: Elaborazioni su dati OECD Health Statistics 2025.

Osservando l'evoluzione della composizione della spesa, ed in particolare il mix delle diverse fonti, si nota come tra il 2022 e il 2023 sia diminuita di poco la percentuale di spesa pubblica (da 73,53 a 72,88 per l'Italia) mentre sia aumentata di poco la percentuale di spesa per compartecipazione (da 23,32 a 23,65 per l'Italia); è aumentata anche la spesa per assicurazioni private (da 2,97 a 3,28 per l'Italia) e sono variati i valori assoluti (sempre per l'Italia notiamo un aumento proporzionale delle tre componenti). Questo andamento ci mostra come le tre componenti rilevanti nel sistema italiano siano legate tra loro e seguano dinamiche simili, in linea con quanto osservato anche in altri Paesi europei.

3.3 I dati nazionali di finanziamento e spesa del SSN

3.3.1 Il finanziamento del SSN

Prima di illustrare i dati riferiti al sistema italiano è bene chiarire il concetto di «finanziamento del SSN» con il quale si fa riferimento, in genere, a due concetti differenti:

1. Il primo è il finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, ovvero l'insieme delle assegnazioni *ex-lege* destinate alla copertura della spesa sanitaria: si tratta, quindi, di una voce di preventivo di competenza del livello nazionale. Non corrisponde perciò alla totalità delle risorse disponibili ma si tratta di una delle fonti di finanziamento del SSN.
2. Il secondo concetto, invece, fa riferimento alle risorse complessivamente disponibili per il SSN (riportate anche a livello nazionale nei conti ministeriali con la dicitura "ricavi del SSN"). Con questa seconda accezione si fa riferimento all'insieme delle fonti di finanziamento provenienti da diversi livelli (pubblica internazionale, nazionale, regionale ma anche privata da singoli cittadini e istituzioni private). Deve essere necessariamente considerata a consuntivo in quanto molte di queste fonti non prevedono un'assegnazione iniziale ma sorgono in corso di esercizio. In questo caso, la dicitura ricavi è coerente con la necessità di considerare tutte le risorse, sia quelle assegnate ex ante ma anche quelle collegate a specifici servizi ed attività erogate. Infatti, nella voce "finanziamento del SSN" rientrano i trasferimenti dal settore pubblico, le entrate proprie effettivamente riscosse dagli enti del SSN[5] e i trasferimenti da soggetti privati.

[5] Soprattutto ticket e proventi per le attività intramoenia.

In questo capitolo vengono presentati dati ed evidenze relativi ad entrambe le interpretazioni, specificando di volta in volta a quale si fa riferimento. Invece è solo in relazione al secondo concetto di ricavi del SSN che viene qui calcolato il disavanzo, diversamente da quanto fa ordinariamente il MEF. Si ritiene, in questa sede, che l'autofinanziamento dei SSR e le entrate proprie siano elementi costitutivi della valutazione della sostenibilità economica di un sistema pubblico. Infatti, rispetto a quanto inizialmente previsto e stanziato in sede di Legge di Stabilità, di Patto per la Salute e di Conferenza Stato-Regioni, nella fase di consuntivazione si possono riscontrare differenze nel valore complessivo dei finanziamenti. Queste ultime possono essere dovute a:

- ulteriori risorse aggiuntive a carico dello Stato e delle Regioni e delle Province Autonome, stanziate a titolo di ripiano dei disavanzi o integrative del finanziamento per i LEA e/o per interventi in campo sanitario previsti da successive norme di legge;
- ulteriori trasferimenti di altri enti pubblici e privati[6];
- eventuali correzioni all'ammontare delle assegnazioni, dovute a provvedimenti assunti in corso di esercizio;
- maggiori o minori ricavi ed entrate proprie.

Il finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato

Per l'anno 2024, il livello di finanziamento complessivo da destinare alla spesa del SSN cui ha concorso ordinariamente lo Stato era stato inizialmente definito in 128.061,00 milioni di Euro (L. 197/2022).

Tale valore è stato successivamente incrementato nella misura di 5.956,00 milioni di Euro (il dettaglio di destinazioni, singoli importi e relativi riferimenti normativi è riportato nella Tabella 3.1).

A fronte di tali incrementi, che determinano un finanziamento pari a 134.017,00 milioni di Euro, è stato previsto un vincolo di destinazione per il finanziamento del Fondo per il concorso statale al rimborso alle Regioni per l'acquisto di medicinali innovativi (L. 232/2016, art. 1, c. 401), pari a 964 milioni di Euro.

Al netto di questo importo vincolato, il finanziamento finale è stato quantificato in 133.053,00 milioni di Euro (133,0 miliardi), con un incremento assoluto di 4.992,00 milioni di Euro (circa 5 miliardi) rispetto al livello di stanziamento inizialmente previsto (in sede di preventivo e assegnazioni iniziali).

[6] Si ricomprendono gli ulteriori trasferimenti, oltre la quota parte del fabbisogno nazionale ripartito dal CIPE, dalla regione o dalla P.A. a carico dei loro bilanci, nonché quelli dal settore pubblico (altre amministrazioni statali, province, comuni) e da quello privato, desunti dal SIS.

Tabella 3.1 **Importi ad incremento (o decremento) del finanziamento iniziale per il 2024**

Importo (milioni di euro)	Descrizione	Riferimento normativo
300,00	Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi	L. 234/2021, art. 1, c. 259
347,00	Aumento del numero di contratti di formazione specialistica dei medici	L. 234/2021, art. 1, c. 260
2.300,00	Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato	L. 197/2022, art. 1, c. 535
5,00	Attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione	L. 197/2022, art. 1, c. 588
3.000,00	Incremento del valore complessivo del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato	L. 213/2023, art. 1, c. 217
2,00	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al fine di finanziare ulteriormente il «bonus psicologo»	D.L. 215/2023, art. 4, c. 8-quater, convertito con L. 18/2024
2,00	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard finalizzato ad un ulteriore finanziamento del «bonus psicologo»	D.L. 113/2024, art. 11, c. 5-bis e 5-ter, convertito con L. N.142/2024

Fonte: Delibera n. 88/2024. Fondo sanitario nazionale 2024. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (GU Serie Generale n. 25 del 31-01-2025).

In merito alla destinazione del finanziamento, lo stanziamento è stato diviso in cinque componenti:

1. finanziamento indistinto: 128.600,23 milioni di Euro (128,6 miliardi; 96,7% del finanziamento). Questo valore, comprensivo anche delle quote cosiddette finalizzate nei precedenti riparti, è ottenuto come differenza tra lo stanziamento totale e la somma di stanziamenti vincolati e programmati per regioni e provincie autonome, stanziamenti vincolati per altri enti e accantonamenti (di cui sotto). Tale finanziamento è genericamente riferito all'esecuzione delle prestazioni rientranti nei LEA;
2. finanziamento vincolato e programmato[7] per regioni e PP.AA. per raggiungimento obiettivi PSN: 2.306,83 milioni di Euro (2,3 miliardi; 1,7% del finanziamento);
3. finanziamento finalizzato per regioni e PP.AA. e già ripartito: 340,30 milioni di Euro (0,3% del finanziamento);
4. finanziamento vincolato per altri enti: 1.135,57 milioni di Euro (0,9% del finanziamento);
5. accantonamenti: 670,075 milioni di Euro (0,5% del finanziamento).

[7] Finanziamento per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e ad altre attività previste da specifiche norme di legge (es. finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari OPG, finanziamento della medicina penitenziaria, finanziamento della medicina veterinaria).

Le voci disaggregate di destinazione del finanziamento per il 2024 e le variazioni rispetto al 2023 sono contenute nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2 **Articolazione delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il 2024 e variazione 2023-2024 (milioni di Euro)**

Designazione risorse	Anno 2024	Anno 2023	Variazione 2023-2024
1. Finanziamento indistinto di cui	**128.600**	**123.810**	**3,87%**
1.1 Ospedale Bambin Gesù	275	285	-3,56%
1.2 Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta	48	45	5,41%
1.3 Finanziamento finalizzato	5.922	6.945	-14,73%
1.3.1 Prevenzione e cura fibrosi cistica	4	4	0,00%
1.3.2 Rinnovo convenzioni SSN	69	69	0,00%
1.3.3 Regolarizzazione lavoratori extracomunitari	200	200	0,00%
1.3.4 Riabilitazione patologie connesse a dipendenza da gioco d'azzardo	50	50	0,00%
1.3.5 Vaccini NPNV	186	186	0,00%
1.3.6 Assunzione e stabilizzazione personale SSN	150	150	0,00%
1.3.7 Finanziamento accertamenti diagnostici neonatali obbligatori	34	34	0,00%
1.3.8 Fondi contrattuali dirigenza medica e professioni sanitarie	138	111	24,32%
1.3.9 Trasmissione telematica di certificati medici di infortunio e malattia professionale	30	26	12,68%
1.3.10 Copertura soppressione cd. superticket	554	554	0,00%
1.3.11 Concorso al finanziamento interventi titolo primo D.L. 34/2020	1.000	1.000	0,00%
1.3.12 Spesa per personale per piano territoriale e ospedaliero (artt. 1-2 D.L. 34/2020)	1.116	1.116	0,00%
1.3.13 Indennità tutela malato e promozione salute per professioni sanitarie, assistenti sociali e OSS	100	100	0,00%
1.3.14 Incremento indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria	500	500	0,00%
1.3.15 Incremento indennità di specificità infermieristica	335	335	0,00%
1.3.16 Indennità di natura accessoria per dirigenza medica e personale del comparto sanità	90	90	0,00%
1.3.17 Aggiornamento LEA	250	200	25,00%
1.3.18 Finanziamento Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Pan-Flu) 2021-2023	–	314	-100,00%
1.3.17 Indennità di pronto soccorso per dirigenza medica	87	30	2
1.3.18 Indennità di pronto soccorso per personale comparto sanità	203	70	2
1.3.19 Contributo per maggiori costi determinati da aumento prezzi fonti energetiche	–	1.400	-1
1.3.20 Recupero liste d'attesa	506	365	0
1.3.21 Finanziamento fondo IRCCS per acquisto prestazioni sanitarie di alta specialità per cittadini extra-regione	40	40	–
1.3.22 Finanziamento incrementi tariffe orarie prestazioni aggiuntive del personale medico	200		
1.3.23 Finanziamento incrementi tariffe orarie prestazioni aggiutive personale comparto sanità	80		
1.3.24 Finanziamento proroga USCA	–	–	–
1.3.25 Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza	–	–	–

Designazione risorse	Anno 2024	Anno 2023	Variazione 2023-2024
1.3.26 Attivazione di incarichi di lavoro autonomo a psicologi	–	–	–
1.3.27 Recupero liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero	–	–	–
2. Finanziamento vincolato e programmato per Regioni e PP.AA.	**2.307**	**2.228**	**3,55%**
2.1 Obiettivi PSN	1.500	1.500	0,00%
2.2 Emergenza veterinaria	64	40	60,28%
2.3 Emersione lavoratori extracomunitari	340	340	0,00%
2.4 Finanziamento prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS	20	20	0,00%
2.5 Piano straordinario per assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario per garantire esigibilità dei LEA nella Regione Calabria	12	12	0,00%
2.6 Attività di medicina penitenziaria	7	7	0,00%
2.7 Accantonamenti medicina penitenziaria	165	165	0,00%
2.8 Superamento ospedali psichiatrici giudiziari	55	55	0,00%
2.9 Borse di studio medici medicina generale	74	74	0,00%
2.10 Potenziamento attività di prevenzione e rafforzamento servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per sicurezza luoghi di lavoro	10	10	0,00%
2.11 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – Contributo di solidarietà per la Regione Calabria	60		
2.12 Psicoterapia presso specialisti privati	–	5	-100,00%
2.13 Finanziamento implementazione standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per potenziamento assistenza territoriale	–	–	–
2.14 Finanziamento dei maggiori costi per aumento dei prezzi delle fonti energetiche	–	–	–
2.15 Riabilitazione termale motoria e neuromotoria, riabilitazione termale del motuleso e riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria	–	–	–
2.16 Finanziamento dei maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia	–	–	–
3. Finalizzato per Regioni e PP.AA. e già ripartito	**340**	**225**	**51,55%**
3.1 Potenziamento dell'assistenza territoriale e il reclutamento di personale extra PNRR	328		
3.1 Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid	–	4	-100,00%
3.2 Incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive per personale medico ed infermieristico	–	70	-100,00%
3.3 Finanziamento nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale	–	150	-100,00%
3.4 Potenziamento assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica	–	–	–
3.5 Bonus psicologo	12	–	–
4. Finanziamento vincolato per altri enti	**1.136**	**1.098**	**3,38%**
4.1 Oneri contrattuali personale Istituti zooprofilattici	39	37	5,79%
4.2 Istituti zooprofilattici sperimentali	272	266	2,26%
4.3 Croce Rossa Italiana	6	6	0,00%
4.4 Centro Nazionale Trapianti	2	2	0,00%
4.5 Mutui Cassa depositi e prestiti	3	3	0,00%
4.6 Borse di studio specializzandi	814	785	3,69%
5. Accantonamenti	**670**	**644**	**3,99%**
TOTALE	**133.053**	**128.005**	**3,94%**

Fonte: Delibera n. 88/2024. Fondo sanitario nazionale 2024. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (GU Serie Generale n. 25 del 31-01-2025).

Per il 2024, le percentuali di finanziamento da attribuire ai sub-livelli assistenziali sono stati determinati come segue:

- distrettuale: 51,5%;
  - territoriale: 20,00%[8];
  - specialistica: 11,00%[9];
  - farmaceutica: 15,50%[10];
  - medicina di base: 5,00%;
- ospedaliera: 44%;
- prevenzione: 4,5%.

Per la definizione dell'assegnazione del finanziamento a livello regionale per l'anno 2024, in linea con il triennio 2021-2023, sono state considerate cinque (invece di tre) regioni di riferimento[11]: Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Umbria. Per il 2024, in linea con quanto previsto per l'anno 2023, vi è stata una revisione dei criteri di riparto del finanziamento indistinto (decreto 30 dicembre 2022, GU Serie Generale n.22 del 27-01-2023), che sono stati così definiti:

- 98,5% delle risorse disponibili sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età;
- 0,75% delle risorse disponibili in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);
- 0,75% delle risorse disponibili in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari (incidenza della povertà relativa individuale, livello di bassa scolarizzazione, tasso di disoccupazione della popolazione).

La Tabella 3.3 mostra la quota del finanziamento indistinto assegnata a ciascuna regione e PP.AA. per l'anno 2024, in termini assoluti e relativi, e la percentuale di popolazione residente al 1° gennaio 2024 utilizzata per il riparto.

[8] Questa voce comprende i servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, i servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), le strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche).
[9] Questa voce comprende tutte le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate in regime ambulatoriale.
[10] Per quanto concerne il riparto della quota relativa all'assistenza farmaceutica distrettuale, il peso include anche la componente di spesa per i farmaci di classe A distribuiti direttamente o in nome e per conto.
[11] D.L. 198/2022, art. 4, c. 9-quaterdecies, ad integrazione dell'art. 27 del D.lgs. 68/2011.

Tabella 3.3 **Riparto finanziamento indistinto a livello regionale per il 2024 – valori assoluti (milioni di Euro) e quote d'accesso**

	Anno 2024		
	Valori assoluti (milioni di Euro)	Quote di accesso	% popolazione residente (1 gennaio 2023)
Piemonte	9.431,18	7,33%	7,21%
Valle d'Aosta	271,86	0,21%	0,21%
Lombardia	21.565,12	16,77%	16,98%
Bolzano	1.129,11	0,88%	0,91%
Trento	1.170,29	0,91%	0,92%
Veneto	10.586,06	8,23%	8,23%
Friuli VG	2.659,67	2,07%	2,03%
Liguria	3.411,51	2,65%	2,56%
Emilia R	9.716,98	7,56%	7,55%
Toscana	8.117,46	6,31%	6,21%
Umbria	1.904,21	1,48%	1,45%
Marche	3.272,95	2,55%	2,51%
Lazio	12.368,10	9,62%	9,69%
Abruzzo	2.795,97	2,17%	2,15%
Molise	646,45	0,50%	0,49%
Campania	11.942,32	9,29%	9,49%
Puglia	8.517,83	6,62%	6,60%
Basilicata	1.180,40	0,92%	0,90%
Calabria	4.012,58	3,12%	3,12%
Sicilia	10.390,65	8,08%	8,14%
Sardegna	3.509,51	2,73%	2,66%
Totale	**128.600,23**		

Fonte: i) Elaborazione su Delibera n.88/2024. Fondo sanitario nazionale 2024. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2025); ii) Dati ISTAT per popolazione residente.

Le risorse complessivamente disponibili per il SSN

Considerando il complessivo dei ricavi, le risorse disponibili per il SSN[12] per l'anno 2024 (Tabella 3.4) ammontano complessivamente a 143,06 miliardi di Euro, di cui 142,43 miliardi di Euro riferiti alle regioni e alle Province Autonome e 0,63 miliardi di Euro riferiti ad altri enti del SSN finanziati direttamente dallo Stato[13]. Tali valori includono, oltre ai fondi messi a disposizione dal livel-

[12] Dal 2012, sono riportate come ricavi a consuntivo per tutte le regioni e PP.AA. (tra i finanziamenti da altri enti del settore pubblico e dai privati) anche le risorse destinate dalle stesse a copertura dei disavanzi sanitari. Tali fondi derivano dai maggiori introiti fiscali relativi alla maggiorazione delle aliquote IRPEF e IRAP. Il gettito della maggiorazione delle aliquote è contabilizzato come risorsa aggiuntiva erogata dalla regione per la copertura dei LEA.

[13] In particolare, ci si riferisce a: Croce Rossa Italiana (finanziamento corrente), Cassa Depositi e Prestiti (mutui pre-riforma), Università (borse di studio per gli specializzandi), Istituti Zooprofilattici Sperimentali (finanziamento corrente).

lo centrale, le risorse proprie regionali (derivanti ad esempio dalle addizionali d'imposta IRPEF e IRAP[14]), le entrate proprie effettivamente riscosse dagli enti del SSN (ticket), i trasferimenti da altri enti del settore pubblico allargato e dai privati per un ammontare complessivo di 10 Mld di euro, che si aggiungono al finanziamento centrale[15]. Non includono, invece, i proventi della gestione straordinaria[16] e l'intramoenia, che sono portati in detrazione al livello di spesa come da prassi indicata dal Ministero della Salute.

Nel 2024, il rapporto tra finanziamento complessivo del SSN e PIL è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto al 2023 (da 6,4% a 6,6%), avvicinandosi dunque nuovamente al livello del 2022, pari al 6,7% (Tabella 3.5). L'aumento del rapporto è dovuto ad un aumento del numeratore (finanziamento del SSN) rispetto al denominatore (PIL). Il finanziamento medio pro-capite nazionale è di 2.426 Euro (+4,53% rispetto al 2023). Complessivamente, si registra un incremento del 4,5% delle risorse totali[17] rispetto ai valori dell'anno precedente (Tabella 3.4), quantomeno in termini nominali. Questi valori devono infatti essere letti anche alla luce dell'andamento dell'inflazione[18] che ha caratterizzato il 2024 e che è pari al +1,0%, più contenuta rispetto al 2023 (+5,7%) e al 2022 (+8,1%). I dati in termini reali (quindi considerati al netto dell'inflazione[19]) mostrano che il finanziamento complessivo per il 2024 ammonta a 118,43 miliardi di Euro, con una variazione del +3,45% rispetto al 2023 (anno in cui il finanziamento in termini reali era pari a 114,48 miliardi di Euro).

[14] IRPEF: Imposta sul reddito delle persone fisiche; IRAP: Imposta regionale sulle attività produttive.

[15] In questo aggregato sono contabilizzate le quote di partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ripartite dal CIPE, gli ulteriori trasferimenti da parte della regione o della provincia autonoma a carico dei rispettivi bilanci, nonché quelli da parte del settore pubblico allargato (altre amministrazioni statali, province, comuni) e da quello privato, desunti dal SIS.

[16] Per gestione straordinaria si intende un'area del conto economico in cui vengono registrati i costi e i ricavi (oneri e proventi) di natura straordinaria rispetto alla gestione ordinaria dell'azienda e all'esercizio in corso.

[17] A partire dall'anno 2011, le risorse complessivamente disponibili comprendono anche i costi capitalizzati e il riparto della quota premiale. Tale quota sarà ripartita tra le regioni sulla base di diversi criteri legati al conseguimento di determinati obiettivi, quali l'adempimento dei LEA, l'introduzione di una centrale regionale per gli acquisti e l'introduzione di misure atte a garantire l'equilibrio di bilancio.

[18] Variazione media annua dell'indice generale dei prezzi al consumo NIC (fonte: ISTAT)

[19] La spesa in termini reali è calcolata a partire dalla spesa in termini nominali applicando l'indice generale dei prezzi al consumo NIC (media annua).

Tabella 3.4 **Articolazione delle risorse complessivamente disponibili 2024 e variazione 2023-2024**

Ricavi	Miliardi di Euro (2024)	Variazione 2023-2024 (miliardi di Euro)	Variazione 2023-2024 (%)
1. Regioni e PP.AA.	**142,43**	**6,14**	**4,50%**
1.1 Irap e Addizionale Irpef	36,39	4,19	13,02%
1.2 Fabbisogno ex D.L.vo 56/00 (Iva e Accise)	76,08	0,35	0,46%
1.3 Riparto quota premiale	0,67	0,03	3,99%
1.4 Ulteriori Trasferimenti da Pubblico e da Privato	15,91	1,04	7,00%
1.5 Ricavi e Entrate Proprie varie	3,23	0,42	14,89%
1.6 FSN e Quote Vincolate a carico dello Stato	6,45	-0,08	-1,28%
1.7 Costi capitalizzati	2,68	0,19	7,64%
1.8 Rettifiche e utilizzo fondi	1,01	0,01	0,62%
2. Altri enti del SSN	**0,63**	**0,00**	**0,00%**
2.1 Finanziati con Quote Vincolate a carico dello Stato	0,63	0,00	0,00%
TOTALE	**143,06**	**6,14**	**4,48%**

Nota. Gli importi sono al netto dei proventi della gestione straordinaria e di quelli dell'intramoenia.

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025).

3.3.2 La spesa sanitaria

Secondo i dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), riportati dal Ministero della Salute, la spesa sanitaria corrente relativa al 2024 a carico del SSN[20] è stata pari a 143.81 miliardi di Euro e ha subìto un aumento del 5,0% rispetto al 2023 (Tabella 3.5), corrispondente a 6,835 miliardi, e del 3,6% (incremento medio annuo) rispetto al 2019. Il peso della spesa sanitaria pubblica corrente sul PIL aumenta rispetto al 2023, passando dal 6,4% al 6,6%[21]. L'aumento del rapporto è anche in questo caso dovuta ad un aumento più consistente della spesa rispetto al PIL.

La spesa privata corrente nel 2024 mostra un decremento rispetto all'anno precedente, attestandosi a 43,81 miliardi di Euro (*cfr.* Capitolo 6 del presente Rapporto per approfondimenti sulla spesa sanitaria privata).

Complessivamente, dunque, la spesa sanitaria totale corrente (pubblica[22] e privata) è aumentata del 3,3% nel 2024 rispetto all'anno precedente (187,62 miliardi di Euro, pari all'8,6% del PIL, Tabella 3.5), e ha subìto un incremento medio del 3,3% rispetto al 2019. Anche con riferimento alla spesa è bene considerare l'effetto dell'inflazione: il dato totale del 2024 in termini reali (quindi al netto dell'effetto inflazione) corrisponde a 155,31 miliardi di Euro e segna

[20] Regioni, Province Autonome e altri enti.
[21] Eventuali discrepanze con le stime riportate nel Capitolo 6 sono riconducibili all'utilizzo di fonti di dati diverse per la spesa sanitaria.
[22] Inclusi gli ammortamenti dal 2011.

una variazione del +2,3% rispetto al 2023 (anno in cui la spesa totale in termini reali è stata pari a 151,84 miliardi di Euro).

Guardando al sistema di welfare nel suo complesso, nel 2024, la spesa per le prestazioni di protezione sociale è cresciuta del 4,39% rispetto al 2023 e del 3,8% (incremento medio) rispetto al 2019 (Tabella 3.6). Nello stesso anno, la sanità ha assorbito una quota di spesa del 20,8%, inferiore ai livelli pre-COVID (21,2% nel 2019). La previdenza[23] continua a registrare il peso maggiore sulle spese per prestazioni di protezione sociale (69,7%), in aumento rispetto agli anni pre-pandemia. Rispetto al 2023, la spesa per assistenza[24] ha subìto una contrazione, pari al -5,7%. L'andamento tendenziale dal 2010 evidenzia come la spesa per la sanità, nonostante l'emergenza pandemica, sia cresciuta meno rispetto alla spesa per previdenza (CAGR[25] +1,6% vs +2,7%).

A fronte di una spesa pubblica corrente pari a 143,81 miliardi di Euro e ad un finanziamento complessivo pari a 143,06 miliardi di Euro, nel 2024 si registra un disavanzo di circa 752 milioni di Euro (0,5% della spesa sanitaria pubblica corrente, Figura 3.5). Già nei precedenti Rapporti è stata ampiamente sottolineata la tendenza consolidata al mantenimento del pareggio di bilancio, confermata dalla capacità, pur nell'emergenza, di chiudere l'esercizio con un disavanzo contenuto e pressoché fisiologico nei suoi importi, soprattutto se confrontato con i livelli annuali di disavanzo prodotti prima del 2012. È utile ribadire, tuttavia, che questa considerazione sul contenimento del disavanzo riguarda esclusivamente la tenuta dei conti e non rappresenta, in alcun modo, una valutazione della capacità del sistema di erogare l'assistenza in modo universale, equo ed efficiente; tanto più che, a partire dal 2022, l'analisi degli avanzi e disavanzi a livello regionale (si veda il paragrafo successivo) segnala un ritorno a significativi entità di disavanzo in alcune regioni, portandoci a osservare diverse strategie regionali nella di ricerca di un equilibrio tra livelli quali-quantitativi assistenziali garantiti e sostenibilità finanziaria, compresi differenziali di sforzo fiscale e tariffario locale.

In tale quadro, è opportuno sviluppare un'ulteriore riflessione sull'entità dei disavanzi regionali che, pur risultando formalmente contenuti in temini percentuali rispetto alla spesa, riflettono comunque tensioni nell'auspicabile equilibrio dei bilanci regionali. Occorre considerare che la lettura dell'equilibrio di bilancio dipende dal diverso grado di maturazione istituzionale del

[23] Rientrano in questo aggregato: pensioni e rendite, liquidazioni per fine rapporto di lavoro, indennità per malattia/infortunio/maternità, indennità di disoccupazione, assegno integrazione salariare, assegni familiari, altri sussidi e assegni.

[24] Rientrano in questo aggregato: pensione e assegno sociale, pensione di guerra, prestazioni agli invalidi civili, prestazioni ai non vedenti e non udenti, altri assegni e sussidi.

[25] Il CAGR (Compound Average Growth Rate) misura il tasso di crescita medio annuale. Ad esempio, per un periodo triennale il CAGR è pari a: (Valore ultimo anno/Valore primo anno)^(1/3)-1.

Tabella 3.5 **Spesa SSN per la gestione corrente e relativo finanziamento; disavanzo; spesa sanitaria privata corrente; spesa totale corrente; PIL (1990, 1995, 2000, 2001, 2005, 2010, 2015, 2019-2024) (milioni di Euro)**

	1990	1995	2000	2001	2005	2010	2015	2019
Spesa SSN (corrente)	41.466	48.752	70.173	77.686	96.797	111.331	114.578	120.340
– variazione %	*-*	*-0,6%*	*11,1%*	*10,7%*	*6,1%*	*1,0%*	*0,3%*	*1,1%*
– % sulla spesa sanitaria corrente totale	*82,6%*	*73,8%*	*73,9%*	*75,6%*	*78,2%*	*78,2%*	*76,2%*	*75,5%*
– % sul PIL	*5,8%*	*4,9%*	*5,6%*	*5,9%*	*6,5%*	*6,9%*	*6,9%*	*6,7%*
Ricavi netti	34.737	47.773	66.945	73.908	91.062	109.135	113.909	120.233
– variazione %	*-*	*5,7%*	*12,7%*	*10,4%*	*7,4%*	*2,1%*	*-0,5%*	*1,1%*
– % sul PIL	*4,8%*	*4,8%*	*5,4%*	*5,6%*	*6,1%*	*6,7%*	*6,8%*	*6,7%*
Avanzo/disavanzo	-6.729	-979	-3.228	-3.778	-5.735	-2.196	-669	-107
– variazione %	*-*	*74,5%*	*13,9%*	*-17,0%*	*10,7%*	*34,7%*	*-398,4%*	*2,4%*
– % sui ricavi netti	*19,4%*	*2,0%*	*4,8%*	*5,1%*	*6,3%*	*2,0%*	*0,6%*	*0,1%*
Spesa sanitaria privata corrente	8.707	17.299	24.799	25.029	26.909	30.577	36.461	39.061
– variazione %	*-*	*13,0%*	*4,5%*	*0,9%*	*-0,6%*	*1,5%*	*5,2%*	*1,3%*
– % sulla spesa sanitaria corrente totale	*17,4%*	*26,2%*	*26,1%*	*24,4%*	*21,8%*	*21,5%*	*24,2%*	*24,5%*
Totale spesa sanitaria corrente	50.173	66.051	94.972	102.715	123.706	142.324	150.385	159.401
– variazione %	*-*	*2,7%*	*9,3%*	*8,2%*	*4,6%*	*1,0%*	*1,5%*	*1,1%*
– % sul PIL	*7,0%*	*6,7%*	*7,6%*	*7,8%*	*8,3%*	*8,8%*	*9,0%*	*8,8%*
PIL	719.131	990.520	1.244.744	1.308.623	1.499.073	1.617.944	1.663.278	1.804.068
– variazione %	*-*	*10,0%*	*5,7%*	*5,1%*	*2,9%*	*2,1%*	*1,7%*	*1,5%*

Note:
– Dati del NSIS: di consuntivo per tutti gli anni.
– Le spese relative all'ospedale «Bambino Gesù» e al Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) sono imputate alle funzioni «Specialistica convenzionata e accreditata» e «Ospedaliera accreditata». È esclusa la svalutazione di crediti e attività finanziarie e, fino al 2010, sono esclusi anche gli ammortamenti. A partire dall'anno 2011 sono stati inclusi nella spesa gli ammortamenti e nel finanziamento i costi capitalizzati, che consentono la sterilizzazione degli ammortamenti in termini di performance economica, secondo le regole definite dal Tavolo di verifica nella riunione del 24 marzo 2011 concernente l'avvio del processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto dall'Intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009 e dai decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale. Dal 2012, in relazione all'entrata in vigore del D.lgs 118/2011 e alla definizione di principi contabili uniformi contenuti nell'articolo 29 del predetto decreto legislativo, gli ammortamenti sono stati considerati nel loro totale complessivo risultante dal modello CE, così come dal lato dei ricavi per i costi capitalizzati. Sempre in relazione all'entrata in vigore del D.lgs 118/2011 a partire dall'anno 2012, l'aggregato della spesa sanitaria include anche il saldo delle voci rivalutazioni e svalutazioni.

dato, che evolve progressivamente dalla prima trasmissione contabile (NSIS) alla verifica tecnica dei Tavoli interministeriali, fino al consolidamento finale che vede l'aggiornamento conclusivo dei saldi e l'inclusione delle coperture regionali ritenute ammissibili. In effetti, laddove i dati proposti della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito dei Tavoli per la verifica degli adempimenti

2020	2021	2022	2023	2024	Tasso crescita medio '90/'24	Tasso crescita medio '95/'01	Tasso crescita medio '01/'10	Tasso crescita medio '10/'24	Tasso crescita medio '19/'24
126.832	130.577	134.114	136.975	143.810	3,7%	8,1%	4,1%	1,8%	3,6%
5,4%	*3,0%*	*2,7%*	*2,1%*	*5,0%*					
77,8%	*76,1%*	*75,6%*	*75,4%*	*76,7%*					
7,6%	*7,1%*	*6,7%*	*6,4%*	*6,6%*					
126.936	130.560	133.829	136.920	143.058	4,3%	7,5%	4,4%	2,0%	3,5%
5,6%	*2,9%*	*2,5%*	*2,3%*	*4,5%*					
7,6%	*7,1%*	*6,7%*	*6,4%*	*6,5%*					
104	-17	-285	-55	-752					
197,2%	*-116,0%*	*-1610,4%*	*80,7%*	*-1266,2%*					
0,1%	*0,0%*	*0,2%*	*0,0%*	*0,5%*					
36.097	41.094	43.222	44.630	43.808	4,9%	6,3%	2,2%	2,6%	2,3%
-7,6%	*13,8%*	*5,2%*	*3,3%*	*-1,8%*					
22,2%	*23,9%*	*24,4%*	*24,6%*	*23,3%*					
162.929	171.671	177.336	181.605	187.618	4,0%	7,6%	3,7%	2,0%	3,3%
2,2%	*5,4%*	*3,3%*	*2,4%*	*3,3%*					
9,8%	*9,3%*	*8,9%*	*8,5%*	*8,6%*					
1.670.013	1.842.507	1.998.072	2.131.391	2.192.181	3,3%	4,8%	2,4%	2,2%	4,0%
-7,4%	*10,3%*	*8,4%*	*6,7%*	*2,9%*					

– Dal 2013, poiché nel riparto compare la mobilità internazionale, essa è stata considerata nel conteggio della spesa. È valorizzata, però, in base ai modelli CE, in termini di saldo tra attiva e passiva.
– Il dato di spesa per la gestione corrente comprende i finanziamenti (pari alla spesa) con quote vincolate a carico dello Stato per gli altri Enti.
– La voce «Ricavi netti» comprende la somma dei ricavi al netto di quelli relativi alla gestione straordinaria e all'intramoenia. Il dato di finanziamento (ricavi) include le diverse integrazioni «in itinere» o «ex post» rispetto alle assegnazioni iniziali. Vengono inoltre incluse, dal 2012, le risorse aggiuntive stanziate dalle regioni a titolo di ripiano dei disavanzi (o di copertura di prestazioni extra-LEA). Nel livello di finanziamento non sono state considerate le Rivalutazioni finanziarie. Dal 2011 sono considerati i costi capitalizzati e dal 2012 anche le rettifiche e utilizzo fondi.
– I dati relativi al PIL sono di fonte International Monetary Fund (IMF) - World Economic Outlook Database (October 2024).
– La spesa sanitaria privata corrente è ottenuta da ISTAT, sezione conti nazionali (aggiornamento settembre 2024).

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025), ISTAT (2025), IMF (2025).

(ex comma 174, L. 311/2004) evidenziano per gli anni 2022 e 2023 disavanzi pari rispettivamente a 1,49 miliardi e 1,85 miliardi di euro (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato, 2024), i valori oggi disponibili in riferimento agli anni 2022 e 2023, aggiornati dal Ministero della Salute tramite il sistema NSIS, mostrano disavanzi pari rispettivamente a 285

Tabella 3.6 **Spesa per le prestazioni di protezione sociale (1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2019-2024)**

	1990	1995	2000	2001	2005	2010	2015	2019
Sanità								
spesa (milioni Euro)	38.790	44.357	63.267	70.131	89.868	104.770	102.788	107.724
% sul totale	26,5%	20,2%	22,5%	23,6%	25,0%	23,8%	21,8%	21,2%
var. %	-	-1,6%	12,4%	10,8%	6,6%	2,3%	0,2%	0,9%
Previdenza								
spesa (milioni Euro)	96.413	159.348	200.189	207.856	244.429	300.726	322.296	344.038
% sul totale	65,7%	72,7%	71,0%	69,9%	67,9%	68,4%	68,4%	67,9%
var. %	-	17,5%	2,2%	3,8%	3,3%	3,3%	0,9%	2,9%
Assistenza								
spesa (milioni Euro)	11.447	15.415	18.351	19.499	25.792	34.218	45.807	55.207
% sul totale	7,8%	7,0%	6,5%	6,6%	7,2%	7,8%	9,7%	10,9%
var. %	-	1,5%	4,5%	6,3%	1,5%	-2,8%	9,3%	5,7%
Totale	**146.650**	**219.120**	**281.807**	**297.486**	**360.089**	**439.714**	**470.891**	**506.969**
var. %	-	11,9%	4,5%	5,6%	4,0%	2,6%	1,5%	2,8%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT (2025)

e 55 milioni di euro, da ritenersi consolidati per quel biennio. Per il 2024, il disavanzo di 752 milioni di euro rilevato dai conti NSIS deve essere considerato provvisorio, in quanto si tratta del dato riferito al risultato d'esercizio dei CE delle aziende, che comprende le coperture regionali provvisorie, e poiché il Tavolo per la verifica degli adempimenti non ha ancora concluso la propria attività di analisi, prevista nel corso del 2026. La Corte dei conti, nel Referto sul coordinamento della finanza pubblica (2025), sulla base delle informazioni ministeriali preliminari, stima infatti un disavanzo pari a circa 1,51 miliardi di euro, coerente con l'andamento osservato negli esercizi precedenti e con la tendenza all'aumento degli squilibri post-verifica. Il quadro che ne emerge è quindi quello di un sistema in cui la ricomparsa di disavanzi strutturali, solo in parte compensati da risorse regionali proprie, evidenzia una crescente tensione nella sostenibilità economico-finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai livelli di servizi che si vorrebbe garantire.

La lettura storica dell'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL permette di ripercorrere le principali tappe evolutive dell'approccio alla gestione delle risorse finanziarie per la sanità (Figura 3.6). Per la metodologia per l'analisi dei trend storici, si rimanda al capitolo 4 del Rapporto OASI 2018 (Armeni *et al.*, 2018) e al Rapporto OASI 2020 (Armeni *et al.*, 2020). Nel 2024, continua da un lato la ripresa del PIL già osservata a partire dal 2021, e dall'altra, la sostanziale stabilità dell'incidenza della spesa sanitaria pubblica, segnale preoccupante rispetto alla possibilità del SSN di allinearsi ai bisogni di salute

2020	2021	2022	2023	2024	Tasso crescita medio '90/'24	Tasso crescita medio '95/'01	Tasso crescita medio '01/'10	Tasso crescita medio '10/'24	Tasso crescita medio '19/'24
114.768	120.788	123.404	123.767	130.054	3,6%	7,9%	4,6%	1,6%	3,8%
20,8%	21,5%	21,4%	20,7%	20,8%					
6,5%	5,2%	2,2%	0,3%	5,1%					
366.760	368.914	383.524	411.699	435.076	4,5%	4,5%	4,2%	2,7%	4,8%
66,5%	65,8%	66,6%	68,9%	69,7%					
6,6%	0,6%	4,0%	7,3%	5,7%					
70.038	71.166	68.806	62.471	58.903	4,9%	4,0%	6,4%	4,0%	1,3%
12,7%	12,7%	12,0%	10,4%	9,4%					
26,9%	1,6%	-3,3%	-9,2%	-5,7%					
551.566	**560.868**	**575.734**	**597.937**	**624.033**	**4,4%**	**5,2%**	**4,4%**	**2,5%**	**4,2%**
8,8%	1,7%	2,7%	3,9%	4,4%					

espressi dal Paese in fase di rapido invecchiamento, anche considerando gli investimenti e le ripercussioni operativo-gestionali sui servizi che dovrebbero conseguire la piena implementazione del PNRR.

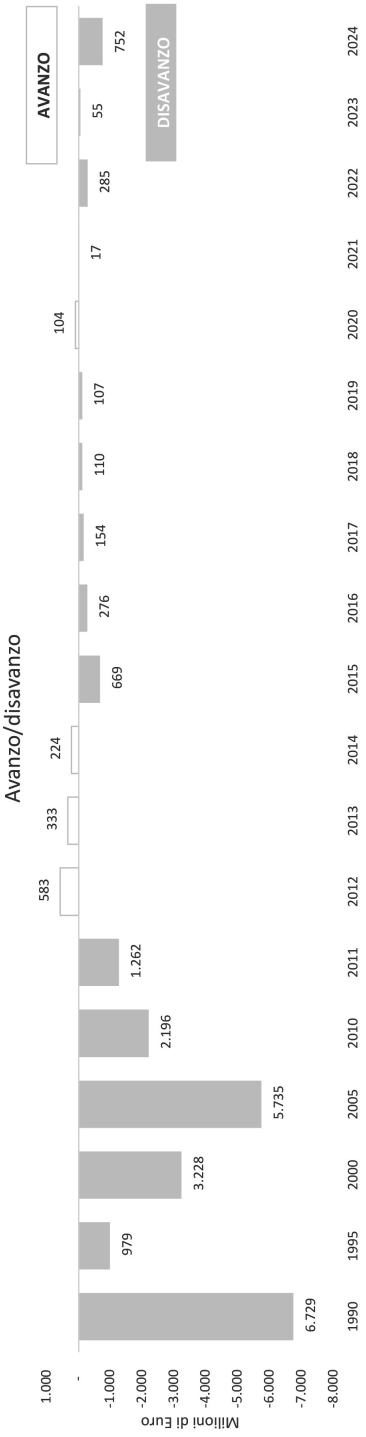
3.4 Il posizionamento delle regioni: livelli di spesa e scelte di finanziamento

Nel 2024, la spesa sanitaria pubblica corrente pro-capite[26] (in termini nominali, quindi al lordo dell'inflazione) è stata pari a 2.425 Euro, con un tasso di crescita rispetto al 2023 allineato a quello della spesa complessiva (+4,9% vs +5,0%, Tabella 3.7 e Tabella 3.5 rispettivamente). Come già sottolineato nel paragrafo precedente, è importante valutare questi dati alla luce delle dinamiche inflazionistiche, che rendono la spesa sanitaria pubblica corrente pro-capite in termini reali pari a 2.008 Euro per il 2024 e 1.932 Euro per il 2023.

Il dato presenta notevoli differenze tra le regioni e PP.AA., nonostante quasi tutte, con l'eccezione del Molise, abbiano registrato un incremento della spesa sanitaria pubblica corrente pro-capite tra il 2023 e il 2024. L'entità della variazione della spesa pro-capite, significativamente diversa da regione a regione, è

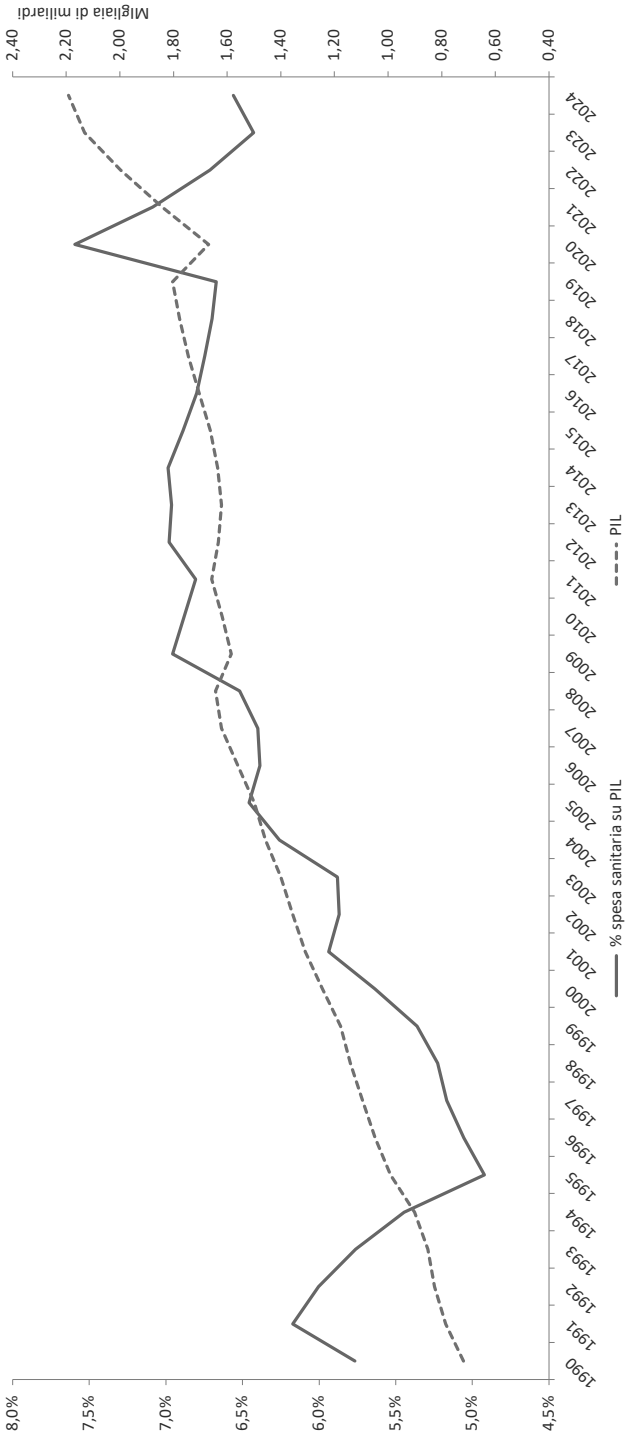
[26] Si considera qui la spesa delle Regioni e PP.AA. (sono esclusi altri enti del SSN finanziati con quote vincolate a carico dello Stato)

Figura 3.5 **Spesa sanitaria pubblica corrente, finanziamento e disavanzo (valori assoluti e in % della spesa sanitaria pubblica corrente) e avanzo/disavanzo (valori assoluti) (1990, 1995, 2000, 2005, 2010-2024)**



Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025)

Figura 3.6 **PIL (asse dx) e rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL (asse sx) (1990-2024)**



Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025), IMF (2025)

frutto di diverse necessità dei territori, nonché di policy e modelli di governance regionale eterogenei che portano a esiti diversi rispetto al finanziamento e alla spesa. La variabilità interregionale, misurata dal coefficiente di variazione[27], nel 2024 è in aumento rispetto agli anni precedenti, con un valore pari a 9,90%.

La Tabella 3.8 e la Figura 3.7 mostrano la spesa sanitaria pubblica pro-capite delle regioni e PP.AA. al lordo della mobilità (spesa riferita all'utilizzo delle strutture della regione), al netto della stessa (spesa riferita alla popolazione residente nella regione) e il saldo pro-capite della mobilità. È da notare come, per alcune regioni, il saldo della mobilità rappresenti una quota significativa della spesa, ad esempio (in negativo) per la Basilicata e la Calabria, e (in positivo) per il Molise, la Lombardia e l'Emilia Romagna (si veda anche la Figura 3.8).

La Tabella 3.9 mostra l'incidenza della spesa sanitaria dei Servizi Sanitari Regionali (SSR) rispetto al PIL regionale. Il dato è da leggere in una doppia prospettiva. Innanzitutto, è da notare come la variabilità tra le regioni di questo indicatore sia molto superiore rispetto a quella della sola spesa (coefficiente di variazione per il 2023: 24,3%). Questa evidenza dimostra che, se l'intensità di spesa è relativamente poco variabile sul territorio, altrettanto non può dirsi della sua incidenza sul PIL, misura di assorbimento potenziale[28] da parte della sanità pubblica delle risorse generate dal sistema produttivo di ogni regione, nonché della rilevanza delle politiche sanitarie per quella regione.

Negli anni, le strategie regionali di copertura dei disavanzi sono state molto eterogenee[29]. Un primo elemento che avrebbe dovuto influenzare i compor-

[27] Calcolato come rapporto tra deviazione standard e media.

[28] Si parla di assorbimento potenziale perché la spesa sanitaria pubblica assorbe solo in parte le risorse generate dai sistemi produttivi regionali. Infatti, i meccanismi di perequazione fanno sì che l'assorbimento reale sia livellato sul territorio, al fine di evitare che la variabilità dell'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL (dal 4,7% in Lombardia fino all'10,2% in Calabria) si trasformi in un ostacolo insormontabile per alcune regioni nell'erogazione dei servizi essenziali. Tale variabilità, infatti, se non fosse livellata tramite il meccanismo perequativo, comporterebbe un'accentuazione delle differenze nella capacità delle regioni di erogare i LEA, se non a prezzo di un forte aumento della pressione fiscale o delle compartecipazioni, oppure di una sostanziale distrazione di risorse da altri ambiti di intervento pubblico nelle regioni in cui l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL è maggiore (soprattutto a causa del minore PIL pro-capite), con margini di manovra molto ristretti in quanto la spesa sanitaria rappresenta una quota molto rilevante della spesa pubblica regionale. In altri termini, la variabilità dell'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL mette in evidenza il trade-off tra finalità di equità del SSN sul territorio nazionale e spinte federaliste verso una maggiore responsabilizzazione delle regioni sul finanziamento e sulla spesa. Questo trade-off è la ragione principale per cui il federalismo fiscale in sanità non è stato mai applicato nella sua forma più radicale.

[29] Con la Legge 405/01, alle regioni è stato attribuito l'onere di coprire i disavanzi sanitari. In particolare l'art. 4 stabilisce che «gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati (…) sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di: misure di compartecipazione alla spesa sanitaria (…); variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente; altre misure idonee a contenere la spesa, ivi

Tabella 3.7 **Spesa sanitaria pubblica pro-capite per la gestione corrente, al lordo della mobilità interregionale (1990; 1995; 2000; 2001; 2005; 2010; 2015; 2019-2024)**

Valori pro-capite (Euro)	1990	1995	2000	2001	2005	2010	2015	2019	2020
Piemonte	688	828	1.319	1.415	1.679	1.924	1.878	2.008	2.111
Valle d'Aosta	756	875	1.409	1.522	1.830	2.188	2.130	2.136	2.368
Lombardia	709	868	1.198	1.344	1.589	1.842	1.941	2.045	2.151
Bolzano	722	995	1.603	1.683	2.067	2.196	2.290	2.460	2.710
Trento	731	907	1.327	1.533	1.731	2.102	2.167	2.288	2.431
Veneto	746	861	1.257	1.365	1.617	1.806	1.851	1.989	2.155
Friuli VG	730	868	1.241	1.361	1.655	1.993	1.979	2.184	2.239
Liguria	841	957	1.374	1.505	1.851	2.036	2.066	2.164	2.240
Emilia R	856	975	1.282	1.422	1.708	1.945	2.033	2.127	2.319
Toscana	788	891	1.256	1.412	1.658	1.911	1.994	2.089	2.254
Umbria	766	865	1.273	1.376	1.646	1.839	1.905	2.020	2.135
Marche	834	886	1.237	1.357	1.571	1.810	1.817	1.951	2.049
Lazio	788	891	1.319	1.464	1.930	2.030	1.927	1.932	2.061
Abruzzo	724	761	1.299	1.383	1.745	1.760	1.814	1.954	2.022
Molise	678	776	1.164	1.387	2.047	2.098	2.094	2.473	2.323
Campania	692	743	1.163	1.300	1.679	1.724	1.728	1.844	1.952
Puglia	671	783	1.123	1.223	1.522	1.769	1.779	1.912	1.988
Basilicata	603	707	1.079	1.184	1.513	1.816	1.851	1.926	2.034
Calabria	586	721	1.142	1.254	1.435	1.750	1.746	1.909	1.952
Sicilia	700	747	1.073	1.254	1.568	1.687	1.758	1.909	2.003
Sardegna	695	860	1.173	1.288	1.644	1.892	2.006	2.076	2.132
Totale	**730**	**846**	**1.223**	**1.356**	**1.660**	**1.856**	**1.889**	**2.001**	**2.116**
Nord	**745**	**891**	**1.265**	**1.393**	**1.659**	**1.897**	**1.950**	**2.068**	**2.198**
Centro	**792**	**894**	**1.284**	**1.426**	**1.773**	**1.948**	**1.932**	**1.990**	**2.125**
Sud e Isole	**678**	**767**	**1.138**	**1.271**	**1.600**	**1.750**	**1.784**	**1.917**	**1.998**
Regioni soggette a piani di rientro						1.822	1.813	1.909	2.003
Regioni non soggette a piani di rientro						1.887	1.959	2.063	2.191
Coefficiente Variazione	**9,55%**	**9,70%**	**9,72%**	**8,47%**	**9,77%**	**7,95%**	**7,82%**	**8,38%**	**8,55%**
Rapporto max/min	**46,2%**	**40,7%**	**49,3%**	**42,2%**	**44,1%**	**30,2%**	**32,5%**	**34,1%**	**38,8%**

Nota: Le regioni inizialmente soggette a PdR sono Lazio (28.2.07), Abruzzo (06.3.07), Campania (13.3.07), Molise (27.3.07) e Sicilia (31.7.07). La Calabria ha approvato il proprio PdR con DGR n.845 del 17.12.2009, pertanto nel 2010 è inclusa nel computo delle regioni in PdR. La Puglia e il Piemonte hanno approvato il PdR nel corso del 2010 (rispettivamente con DGR 2624 del 30.11.2010 e DGR 1-415 del 2.8.2010 e successive integrazioni) e risultano pertanto incluse a partire dal 2010. La Liguria e la Sardegna sono uscite dal Piano nel 2010 ed il Piemonte nel 2017, con valutazione positiva circa il raggiungimento degli obiettivi. La voce regioni in PdR comprende le regioni che allo stato attuale risultano essere in PdR.

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025) e ISTAT (2025)

2021	2022	2023	2024	Variazione ’23/’24	Tasso crescita medio ’90/’24	Tasso crescita medio ’95/’01	Tasso crescita medio ’01/’10	Tasso crescita medio ’10/’24	Tasso crescita medio ’19/’24
2.208	2.242	2.317	2.421	4,5%	3,8%	9,3%	3,5%	1,7%	3,8%
2.510	2.561	2.693	2.881	7,0%	4,0%	9,7%	4,1%	2,0%	6,2%
2.208	2.266	2.323	2.427	4,5%	3,7%	7,6%	3,6%	2,0%	3,5%
2.838	2.876	3.066	3.186	3,9%	4,5%	9,2%	3,0%	2,7%	5,3%
2.478	2.630	2.741	2.896	5,6%	4,1%	9,2%	3,6%	2,3%	4,8%
2.237	2.303	2.391	2.468	3,2%	3,6%	8,0%	3,2%	2,3%	4,4%
2.345	2.440	2.573	2.770	7,7%	4,0%	7,8%	4,3%	2,4%	4,9%
2.342	2.456	2.481	2.569	3,6%	3,3%	7,8%	3,4%	1,7%	3,5%
2.330	2.432	2.468	2.622	6,2%	3,3%	6,5%	3,5%	2,2%	4,3%
2.302	2.359	2.402	2.505	4,3%	3,5%	8,0%	3,4%	2,0%	3,7%
2.226	2.340	2.328	2.442	4,9%	3,5%	8,0%	3,3%	2,0%	3,9%
2.150	2.236	2.277	2.312	1,5%	3,0%	7,4%	3,3%	1,8%	3,5%
2.118	2.173	2.136	2.333	9,2%	3,2%	8,6%	3,7%	1,0%	3,8%
2.089	2.191	2.251	2.353	4,5%	3,5%	10,5%	2,7%	2,1%	3,8%
2.472	2.519	2.567	2.547	-0,8%	4,0%	10,2%	4,7%	1,4%	0,6%
2.058	2.093	2.162	2.283	5,6%	3,6%	9,8%	3,2%	2,0%	4,4%
2.109	2.177	2.232	2.312	3,6%	3,7%	7,7%	4,2%	1,9%	3,9%
2.136	2.214	2.259	2.311	2,3%	4,0%	9,0%	4,9%	1,7%	3,7%
1.965	2.257	2.163	2.243	3,7%	4,0%	9,7%	3,8%	1,8%	3,3%
2.103	2.107	2.178	2.264	4,0%	3,5%	9,0%	3,4%	2,1%	3,5%
2.293	2.379	2.513	2.697	7,3%	4,1%	7,0%	4,4%	2,6%	5,4%
2.194	**2.261**	**2.311**	**2.425**	**4,9%**	**3,6%**	**8,2%**	**3,6%**	**1,9%**	**3,9%**
2.265	**2.334**	**2.401**	**2.514**	**4,7%**	**3,6%**	**7,7%**	**3,5%**	**2,0%**	**4,0%**
2.188	**2.251**	**2.251**	**2.392**	**6,3%**	**3,3%**	**8,1%**	**3,5%**	**1,5%**	**3,7%**
2.099	**2.167**	**2.222**	**2.323**	**4,5%**	**3,7%**	**8,8%**	**3,6%**	**2,0%**	**3,9%**
2.090	2.153	2.181	2.300	5,5%	n.d.	n.d.	n.d.	1,7%	3,8%
2.262	2.333	2.397	2.508	4,6%	n.d.	n.d.	n.d.	2,1%	4,0%
8,67%	**8,13%**	**9,57%**	**9,90%**						
44,4%	**37,4%**	**43,5%**	**42,0%**						

Tabella 3.8 **Spesa sanitaria pro-capite nei SSR per la gestione corrente al lordo (riferimento alle aziende del SSR) ed al netto (riferimento alla spesa sostenuta per i pazienti residenti) della mobilità (2024). Valori assoluti (v.a.) e numeri indice (n.i)**

Regioni	Spesa procapite (lordo mobilità)		Spesa procapite (netto mobilità)		Saldo procapite mobilità	Saldo procapite mobilità/ spesa procapite
	v.a. (Euro)	n.i.	v.a. (Euro)	n.i.	v.a. (Euro)	percentuale
Piemonte	2.421	99,8	2.423	99,9	-1,3	-0,05%
Valle d'Aosta	2.881	118,8	2.978	122,8	-97,0	-3,37%
Lombardia	2.427	100,1	2.364	97,5	62,5	2,57%
Bolzano	3.186	131,3	3.181	131,2	4,4	0,14%
Trento	2.896	119,4	2.883	118,9	13,3	0,46%
Veneto	2.468	101,7	2.427	100,1	41,1	1,66%
Friuli VG	2.770	114,2	2.780	114,6	-9,5	-0,34%
Liguria	2.569	105,9	2.617	107,9	-48,1	-1,87%
Emilia R	2.622	108,1	2.503	103,2	118,7	4,53%
Toscana	2.505	103,3	2.491	102,7	14,2	0,57%
Umbria	2.442	100,7	2.479	102,2	-37,3	-1,53%
Marche	2.312	95,3	2.346	96,7	-34,2	-1,48%
Lazio	2.333	96,2	2.329	96,0	4,2	0,18%
Abruzzo	2.353	97,0	2.429	100,1	-75,3	-3,20%
Molise	2.547	105,0	2.451	101,0	96,0	3,77%
Campania	2.283	94,1	2.335	96,3	-51,2	-2,24%
Puglia	2.312	95,3	2.366	97,6	-54,2	-2,34%
Basilicata	2.311	95,3	2.454	101,2	-143,0	-6,19%
Calabria	2.243	92,5	2.402	99,0	-159,0	-7,09%
Sicilia	2.264	93,3	2.311	95,3	-47,4	-2,10%
Sardegna	2.697	111,2	2.756	113,6	-59,6	-2,21%
Totale	**2.425**	**100,0**	**2.425**	**100,0**	**-0,0**	**-0,00%**
Nord	2.514	103,6	2.468	101,7	45,9	1,83%
Centro	2.392	98,6	2.392	98,6	-0,6	-0,02%
Sud e Isole	2.323	95,8	2.386	98,4	-63,4	-2,73%
Coeff. Var.	**9,9%**		**9,4%**			
Rapporto max/min	**42,0%**		**37,6%**			

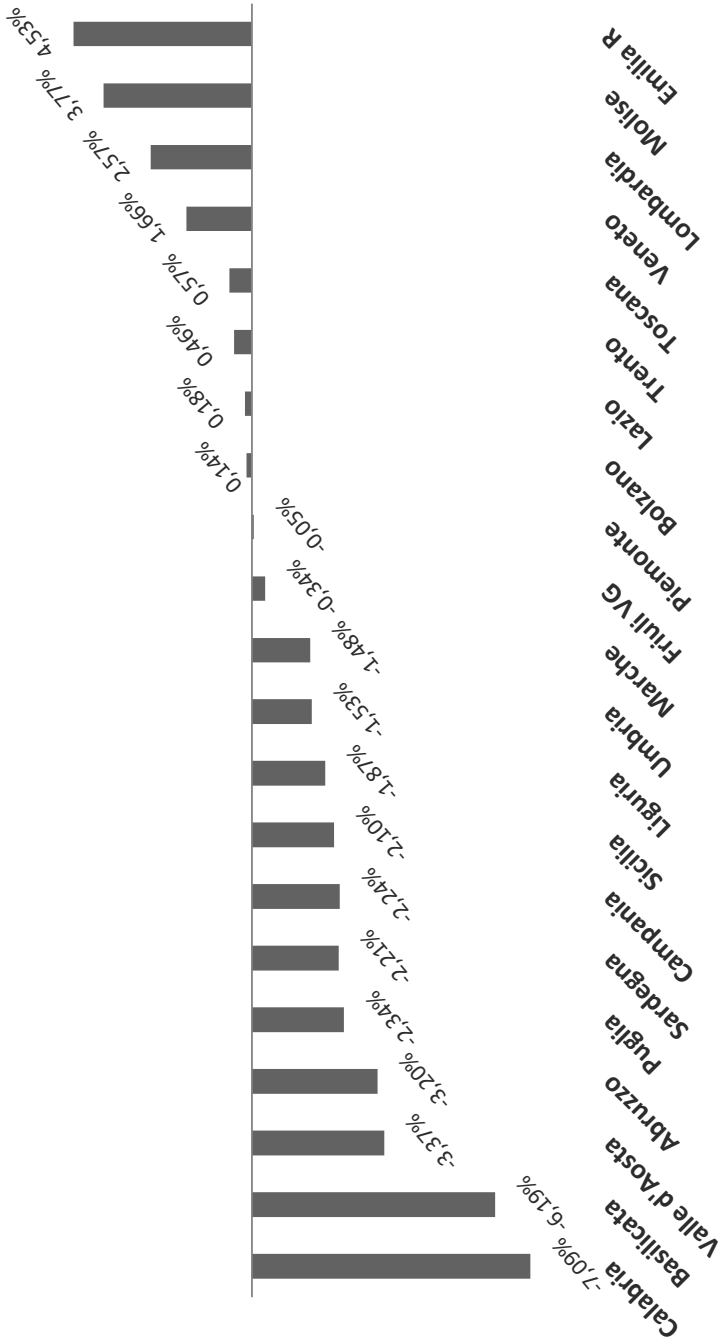
Nota: La mobilità interregionale è quella programmata, come riportata nella matrice di mobilità inserita nella proposta di riparto.

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025)

tamenti regionali è l'entità effettiva dei disavanzi. È necessario, tuttavia, usare molta cautela nell'interpretare i dati di disavanzo: esiste, infatti, una forte variabilità nei sistemi di rilevazione delle voci introdotte a seguito dell'ado-

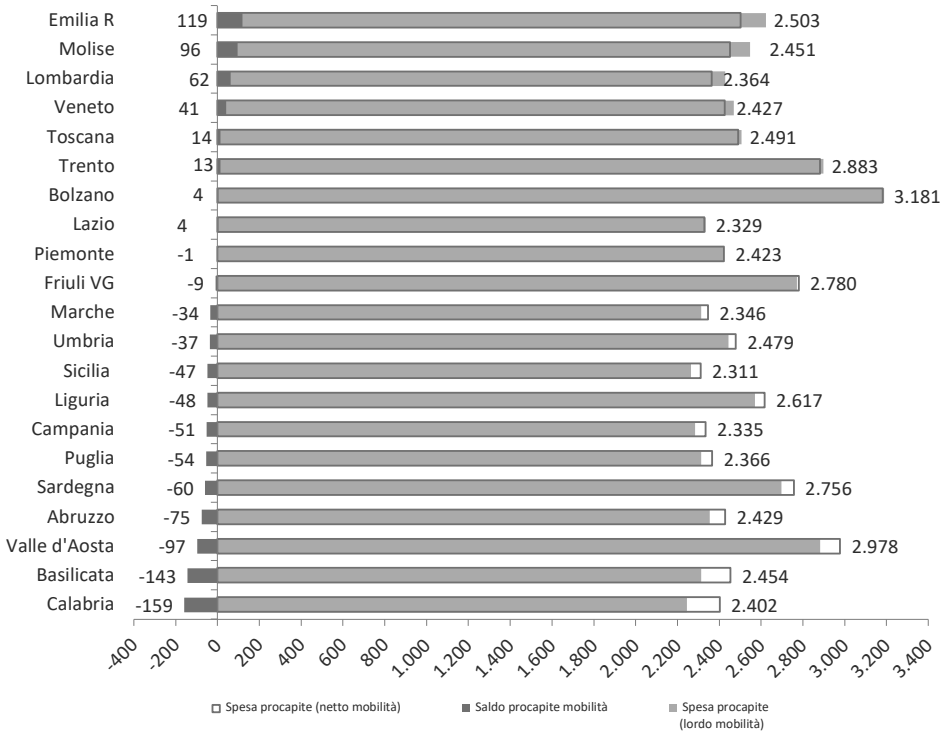
inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci». Con l'accordo tra il Governo, le regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004, sono state definite le iniziative considerate idonee per la copertura degli stessi (Jommi e Lecci, 2005). Il principio di piena responsabilità delle regioni sulla copertura dei disavanzi è stato poi in parte derogato dalle Leggi Finanziarie per gli anni successivi.

Figura 3.7 **Spesa sanitaria pubblica pro-capite nei SSR per la gestione corrente al lordo e al netto della mobilità e saldo della mobilità interregionale pro-capite (2024)**



Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025)

Figura 3.8 **Saldo pro-capite della mobilità su spesa sanitaria pro-capite nei SSR per la gestione corrente al lordo (riferimento alle aziende del SSR) (2024)**



Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025)

zione della contabilità economico-patrimoniale (Anessi Pessina, 2005). A partire dall'implementazione dell'armonizzazione contabile prevista dal D.lgs 118/2011 e quindi dai dati di consuntivo 2012, si registra una netta convergenza delle regioni nella contabilizzazione dei livelli di disavanzo: fino al 2011, questi ultimi erano contabilizzati dalle regioni prevalentemente al lordo delle coperture regionali, mentre dal 2012 sono riportati al netto delle stesse.

Nel 2024, il disavanzo sanitario si attesta a 752 milioni di Euro (Tabella 3.10 e Figura 3.5). A livello regionale si rileva tuttavia eterogeneità nei risultati di gestione, con dodici regioni che registrano risultati di avanzo. Tra queste, il Lazio presenta il dato in valore assoluto più elevato (213 milioni di Euro). Sardegna, Toscana ed Emilia Romagna registrano i livelli di disavanzo più elevati in valore assoluto (239, 197 e 194 milioni di Euro rispettivamente), incidendo sul disavanzo annuale complessivo per il 58%. Le regioni in PdR[30] nel 2024

[30] Tra le regioni in PdR ricomprendiamo le regioni che hanno avviato il PdR nel periodo 2007-

Tabella 3.9 **Incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL regionale (2010-2023)**

Regioni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Piemonte	6,9%	6,7%	7,0%	6,8%	6,8%	6,6%	6,5%	6,4%	6,3%	6,4%	7,3%	6,9%	6,5%	6,3%
Valle d'Aosta	5,9%	5,9%	5,9%	6,1%	5,9%	5,9%	5,8%	5,5%	5,5%	5,5%	6,7%	6,5%	5,9%	5,8%
Lombardia	5,0%	5,1%	5,2%	5,3%	5,3%	5,2%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,7%	5,2%	4,9%	4,7%
Bolzano	5,4%	5,4%	5,4%	5,3%	5,3%	5,2%	5,1%	5,2%	5,1%	5,0%	5,9%	5,7%	5,1%	5,1%
Trento	6,1%	6,3%	6,5%	6,3%	6,3%	6,1%	6,1%	6,2%	6,0%	5,9%	6,7%	6,3%	6,0%	5,9%
Veneto	6,1%	5,9%	6,1%	6,1%	6,0%	6,0%	5,9%	5,9%	5,8%	5,8%	6,8%	6,4%	6,1%	5,9%
Friuli VG	7,1%	7,2%	7,5%	7,3%	7,0%	6,7%	6,7%	6,8%	6,8%	6,8%	7,4%	7,0%	6,8%	6,8%
Liguria	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%	6,9%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	7,6%	7,2%	7,0%	6,6%
Emilia R	6,1%	5,9%	6,4%	6,2%	6,1%	6,0%	5,9%	5,9%	5,8%	5,8%	6,8%	6,1%	6,0%	5,7%
Toscana	6,7%	6,6%	6,9%	6,8%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%	6,5%	6,3%	7,7%	7,1%	6,6%	6,4%
Umbria	7,4%	7,5%	7,8%	7,9%	8,0%	7,9%	8,0%	8,0%	7,9%	7,7%	8,9%	8,4%	8,1%	7,6%
Marche	7,1%	7,0%	7,2%	7,3%	7,1%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%	7,9%	7,5%	7,2%	6,9%
Lazio	5,8%	5,7%	5,9%	5,8%	5,8%	5,8%	5,6%	5,5%	5,4%	5,4%	6,2%	5,9%	5,5%	5,1%
Abruzzo	7,6%	7,3%	7,5%	7,5%	7,7%	7,6%	7,8%	7,7%	7,7%	7,7%	8,6%	8,0%	7,7%	7,3%
Molise	9,8%	9,6%	10,2%	11,4%	11,0%	10,4%	10,6%	10,1%	9,9%	11,2%	11,2%	10,6%	10,1%	9,6%
Campania	9,7%	9,7%	9,6%	9,7%	9,8%	9,7%	9,7%	9,6%	9,7%	9,6%	10,9%	10,3%	9,6%	9,3%
Puglia	10,3%	9,9%	9,8%	10,1%	10,2%	10,1%	10,1%	10,0%	9,9%	10,0%	10,9%	10,4%	9,9%	9,5%
Basilicata	9,7%	9,4%	9,4%	9,1%	9,5%	8,9%	8,9%	9,1%	8,6%	8,6%	10,0%	9,0%	8,6%	8,2%
Calabria	10,4%	10,2%	10,4%	10,4%	10,7%	10,6%	10,6%	10,4%	10,7%	10,9%	11,9%	10,7%	11,5%	10,2%
Sicilia	9,7%	9,9%	10,0%	10,2%	10,5%	10,3%	10,5%	10,5%	10,7%	10,5%	11,7%	11,0%	9,9%	9,5%
Sardegna	9,6%	9,8%	9,9%	10,1%	10,2%	9,9%	10,1%	9,7%	9,7%	9,6%	10,6%	10,2%	9,7%	9,5%
Totale	**6,8%**	**6,8%**	**6,9%**	**6,9%**	**6,9%**	**6,8%**	**6,8%**	**6,7%**	**6,7%**	**6,6%**	**7,6%**	**7,1%**	**6,7%**	**6,4%**
Coeff. di variazione	23,5%	23,1%	22,7%	24,3%	25,2%	24,5%	25,6%	25,2%	25,9%	27,2%	24,2%	24,2%	25,4%	24,3%

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025), ISTAT (2025)

Tabella 3.10 **Disavanzo sanitario regionale: milioni di Euro (2001-2024)**

Regioni	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Piemonte	210	40	100	671	-1	7	-31	-5	-17	2	5	-21	-13	-57	-6	-52	-17	-1	-2	-48	-59	-23	105	126
Valle d'Aosta	33	7	10	13	14	14	14	13	1	4	-2	-1	-7	-3	50	-0	-2	-1	-4	-4	-1	-2	-1	2
Lombardia	281	323	-64	-131	14	4	-10	-4	-2	-20	-14	-2	-10	-6	-15	-6	25	-6	-6	-11	-6	-12	-6	-9
Bolzano	297	71	25	-25	-28	-25	-22	-15	-37	-8	-17	42	5	-11	422	-22	-13	-8	-28	-27	-8	18	-18	-36
Trento	-4	-1	5	9	3	14	8	10	12	12	-2	190	-2	-1	-25	-1	-1	-2	-2	-2	-0	-1	-1	-0
Veneto	304	204	145	-6	114	-71	-75	-68	27	-10	-162	-42	-46	-56	-8	-17	-42	-22	-29	-6	-10	-5	-23	-7
Friuli VG	18	-34	-19	-9	-27	-18	-39	-22	-17	-14	-17	62	-16	-23	-31	-0	30	-3	-9	-22	-1	-1	-5	-3
Liguria	77	44	48	329	254	100	142	110	105	90	143	13	78	64	95	64	61	52	54	-0	1	33	58	97
Emilia R	16	50	40	380	16	38	-26	-27	-22	-28	-55	10	-1	-14	8	2	13	-1	-1	-1	-0	84	-25	194
Toscana	88	44	-20	240	15	121	-42	3	7	16	-14	2	25	-8	26	39	-24	18	13	91	124	73	181	197
Umbria	7	10	46	52	8	41	-7	-9	-5	-9	-12	-20	-7	-10	-5	-7	-0	-4	-0	-0	-0	-1	-3	34
Marche	125	98	71	163	18	39	-15	-37	-17	3	-21	-50	-61	-62	-66	-25	4	-1	-1	-0	-0	-2	-1	-1
Lazio	987	574	711	1.669	1.737	1.971	1.635	1.665	1.396	1.025	775	-204	-31	-0	-3	1	18	-6	-108	-84	0	39	-564	-213
Abruzzo	76	136	216	104	241	140	151	123	95	6	-52	-48	-53	-7	0	37	46	-0	12	15	-14	15	93	104
Molise	37	19	73	44	139	59	67	70	64	58	37	33	70	40	26	-0	1	16	117	23	40	19	20	3
Campania	629	638	556	1.182	1.793	761	864	815	789	479	245	-148	-63	-183	-76	-51	-38	-36	-38	-27	-15	-9	-8	-16
Puglia	166	4	-109	-42	412	170	313	358	302	323	108	-4	5	-5	-10	27	8	46	38	24	133	144	24	84
Basilicata	28	1	19	31	43	22	18	29	21	29	31	-7	-2	-1	7	-10	-3	-2	-1	-4	-1	14	45	37
Calabria	226	148	57	128	79	35	170	202	232	67	110	-44	-76	-41	-43	0	9	97	122	20	-151	-28	-39	-76
Sicilia	415	342	267	748	563	932	574	262	200	29	13	-324	-120	-55	-15	-7	-5	-3	-8	-14	-2	-10	45	-5
Sardegna	106	175	143	240	327	130	22	183	230	143	173	-18	-10	216	339	306	85	-22	-11	-27	-13	-60	175	239
Totale	**4.122**	**2.891**	**2.323**	**5.790**	**5.735**	**4.483**	**3.709**	**3.658**	**3.364**	**2.194**	**1.273**	**-583**	**-333**	**-224**	**669**	**276**	**154**	**110**	**107**	**-104**	**17**	**285**	**55**	**752**
Nord	**1.232**	**704**	**292**	**1.231**	**359**	**63**	**-40**	**-8**	**50**	**27**	**-122**	**250**	**-11**	**-107**	**489**	**-34**	**54**	**8**	**-27**	**-121**	**-84**	**92**	**86**	**364**
Centro	**1.207**	**726**	**808**	**2.125**	**1.779**	**2.171**	**1.571**	**1.623**	**1.382**	**1.035**	**728**	**-272**	**-74**	**-80**	**-47**	**7**	**-2**	**6**	**-97**	**6**	**124**	**108**	**-387**	**17**
Sud e Isole	**1.683**	**1.461**	**1.224**	**2.434**	**3.597**	**2.250**	**2.178**	**2.043**	**1.932**	**1.133**	**666**	**-561**	**-248**	**-36**	**228**	**302**	**103**	**96**	**231**	**11**	**-23**	**85**	**355**	**371**

Nota: Il segno – denota un avanzo, mentre il segno + denota un disavanzo.

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025)

hanno complessivamente registrato un avanzo sanitario, pari a 118 milioni di Euro. La Figura 3.9 mostra i dati di avanzo/disavanzo sia in valore assoluto sia in valore pro-capite per ciascuna regione.

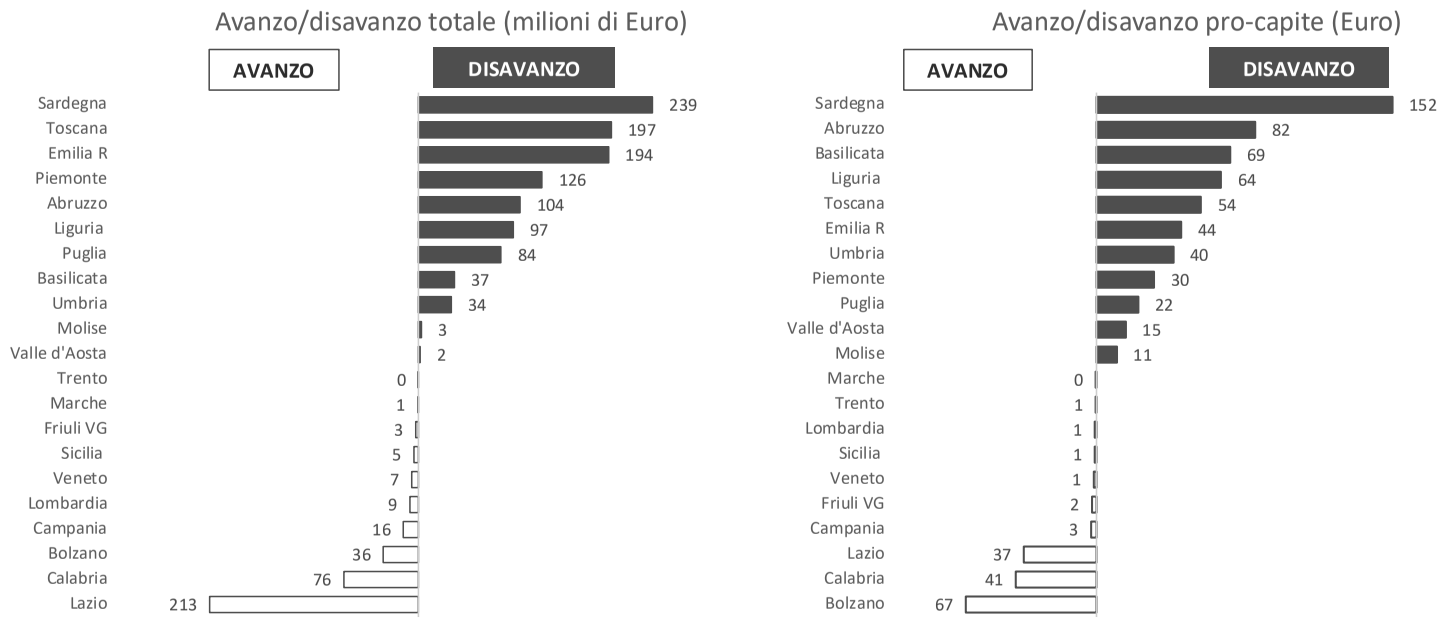
A integrazione del finanziamento derivante dalle scelte allocative di sistema collegate al Fondo Sanitario, le Regioni definiscono autonomamente l'impiego di risorse extra-fondo utili a sostenere l'erogazione dei LEA e/o dei cd. "Extra-LEA", ossia tutti quei servizi che gli SSR si impegnano ad erogare e che non rientrano nei livelli minimi definiti nel quadro nazionale. La Figura 3.10 ne riporta il dettaglio in termini assoluti (parte sinistra della Figura) e pro-capite (parte destra). Sebbene la diversa natura dei valori non consenta una comparazione pienamente esaustiva (disavanzo – dimensione finanziaria; contributi extra-fondo qui proposti – dimensione economica), questa rappresentazione consente di offrire un quadro dell'ordine di grandezza delle risorse che concorrono a contenere la tensione sulla tenuta dei conti del SSN e dei singoli SSR. Nel complesso, esclusa la GSA, queste risorse integrative valgono circa 1.1mld. I singoli SSR producono sforzi evidentemente diversi, in virtù delle diverse finalità attribuite a tali risorse (es. erogazione extra-LEA vs copertura LEA) e delle possibilità d'azione derivanti dalla ricchezza del singolo contesto regionale. Dei 1.1mld complessivi, le risorse proprie regionali formalmente dedicate ai LEA valgono circa 750mln (in linea con quanto riportato da RGS, 2025).

Anche analizzando la composizione regionale della spesa per fattori della produzione, si evidenziano rilevanti differenze a livello regionale. La Tabella 3.11 riporta il dato analitico relativo ai singoli fattori produttivi, che saranno in buona parte ripresi e analizzati nella loro evoluzione tra 2023 e 2024 nei successivi paragrafi 3.5 e 3.6, sebbene con alcune differenze riconducibili alla diversa classificazione impiegata in quella sede.

Le differenze sono da ricondurre in primo luogo al diverso assetto dei SSR, con riferimento, in particolare, al differente mix pubblico/privato nelle strutture di offerta: ad esempio, Lombardia, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sicilia presentano dati di incidenza della spesa per fattori della produzione interni alle aziende sanitarie (personale e beni e servizi) inferiori alla media nazionale, e questo per la rilevante presenza di strutture private accreditate (ospedaliere ed ambulatoriali). Queste regioni presentano, infatti, valori tendenzialmente superiori alla media nazionale per quanto riguarda i servizi accreditati (assistenza ospedaliera, specialistica e altra assistenza). Inoltre, si rileva una forte eterogeneità tra le regioni nel mix dei sopracitati servizi accreditati. È interessante osservare come, con riferimento specifico al personale dipendente nel 2024, Lombardia, Veneto, Lazio, Molise, Campania e Puglia presentino

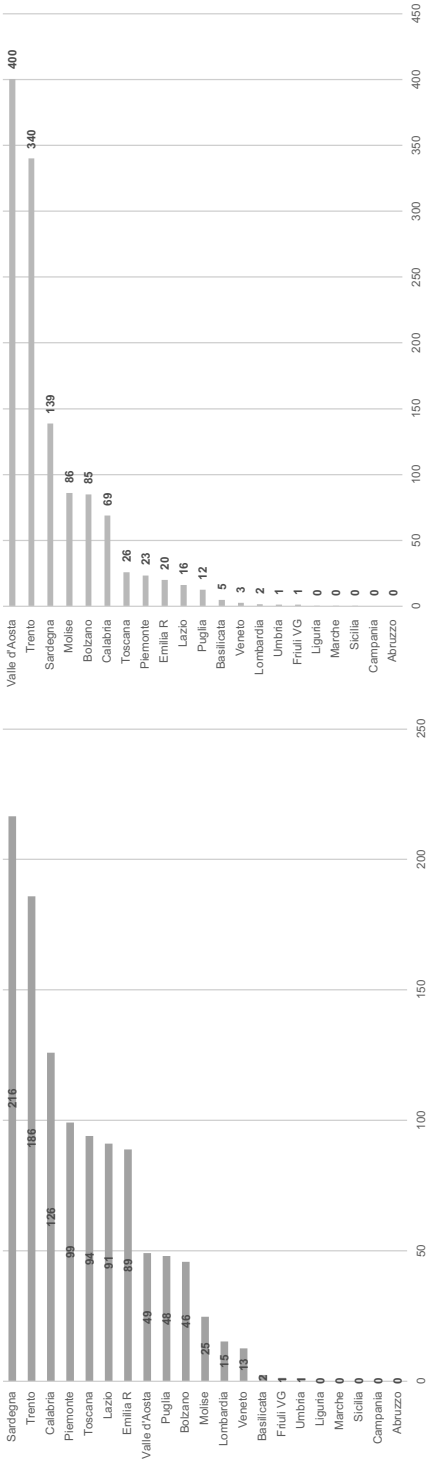
2010 e sono ancora in vigenza di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia. Viene compresa anche l'unica regione con PdR «leggero»: Puglia, che a partire dall'anno 2010 è sottoposta a un piano con un livello di gravosità minore da quello ordinario.

Figura 3.9 **Disavanzo sanitario regionale, valori assoluti e pro-capite (2024)**



Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025)

Figura 3.10 **Le risorse aggiuntive regionali: i contributi extra-fondo sanitario nazionale, valori assoluti (grafico di sinistra – in milioni) e pro-capite (grafico di destra) – 2024**



Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025)

Tabella 3.11 **Incidenza delle voci di spesa sanitaria pubblica nei SSR per la gestione corrente, secondo la classificazione economica, e valore assoluto (in milioni di Euro) (2024)**

	Personale	Beni e servizi	Medicina generale convenzionata	Farmaceutica convenzionata	OspTedaliera accreditata	Specialistica convenzionata e accreditata	Altra assistenza convenzionata e accreditata	Totale (milioni di Euro)	Fattori Interni	Fattori esterni
Piemonte	31,6%	40,6%	4,9%	5,1%	4,6%	2,8%	10,4%	10.372	72,2%	-27,8%
Valle d'Aosta	39,6%	45,0%	4,3%	4,2%	2,3%	0,7%	4,1%	359	84,5%	-15,5%
Lombardia	24,2%	37,7%	4,2%	5,9%	9,6%	5,0%	13,5%	23.954	61,8%	-38,2%
Bolzano	46,9%	32,8%	4,0%	2,6%	2,1%	1,0%	10,5%	1.701	79,7%	-20,3%
Trento	34,0%	36,3%	4,3%	4,2%	4,6%	2,3%	14,2%	1.552	70,3%	-29,7%
Veneto	28,1%	44,2%	4,9%	4,2%	5,2%	3,6%	9,8%	11.707	72,3%	-27,7%
Friuli VG	34,0%	43,7%	4,2%	4,8%	2,0%	2,2%	9,2%	3.273	77,6%	-22,4%
Liguria	32,3%	39,8%	4,0%	4,6%	5,7%	3,4%	10,3%	3.898	72,0%	-28,0%
Emilia R	31,2%	40,7%	4,9%	4,4%	6,2%	2,3%	10,3%	11.636	71,9%	-28,1%
Toscana	32,5%	43,9%	4,8%	4,9%	3,3%	2,2%	8,3%	9.060	76,4%	-23,6%
Umbria	32,8%	45,5%	4,8%	5,4%	2,0%	1,7%	7,9%	2.100	78,3%	-21,7%
Marche	32,9%	39,8%	5,0%	6,2%	3,3%	1,7%	11,1%	3.456	72,7%	-27,3%
Lazio	24,1%	37,1%	4,8%	6,1%	11,6%	4,8%	11,5%	13.030	61,2%	-38,8%
Abruzzo	31,0%	41,9%	5,2%	6,4%	4,7%	1,8%	9,0%	2.951	72,9%	-27,1%
Molise	23,2%	42,5%	5,7%	5,5%	8,4%	5,9%	8,8%	776	65,7%	-34,3%
Campania	26,3%	41,2%	5,1%	6,0%	7,2%	6,6%	7,7%	12.714	67,5%	-32,5%
Puglia	27,1%	38,6%	5,8%	6,1%	8,7%	3,9%	9,8%	8.891	65,8%	-34,2%
Basilicata	32,0%	39,0%	6,3%	7,2%	1,0%	3,8%	10,7%	1.222	71,0%	-29,0%
Calabria	28,9%	42,5%	5,8%	6,7%	4,0%	3,4%	8,8%	4.155	71,5%	-28,5%
Sicilia	28,8%	38,0%	5,2%	5,5%	7,2%	5,1%	10,1%	11.224	66,9%	-33,1%
Sardegna	33,0%	42,8%	4,3%	6,0%	3,1%	3,3%	7,5%	4.175	75,8%	-24,2%
Italia	**28,7%**	**40,2%**	**4,8%**	**5,5%**	**6,7%**	**3,9%**	**10,3%**	**142.204**	**68,8%**	**-31,2%**
Nord	**29,0%**	**40,0%**	**4,5%**	**5,0%**	**6,6%**	**3,6%**	**11,4%**	**68.451**	**69,0%**	**31,0%**
Centro	**28,6%**	**40,3%**	**4,8%**	**5,7%**	**7,1%**	**3,3%**	**10,1%**	**27.645**	**68,9%**	**31,3%**
Sud e Isole	**28,3%**	**40,2%**	**5,3%**	**6,0%**	**6,5%**	**4,7%**	**8,9%**	**46.107**	**68,5%**	**31,5%**

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero della Salute (2025).

incidenze inferiori alla media nazionale. È bene specificare che nella Tabella 3.11 si riportano i dati come da classificazione ministeriale facendo riferimento alle macro-voci di spesa nella prospettiva regionale. Nei paragrafi 3.5 e 3.6 che seguono si proporrà una riclassificazione dei costi basata invece su una logica economica, che osserva e interpreta le dinamiche produttive e di funzionamento delle aziende e dei servizi con un approccio tecnicamente differente.

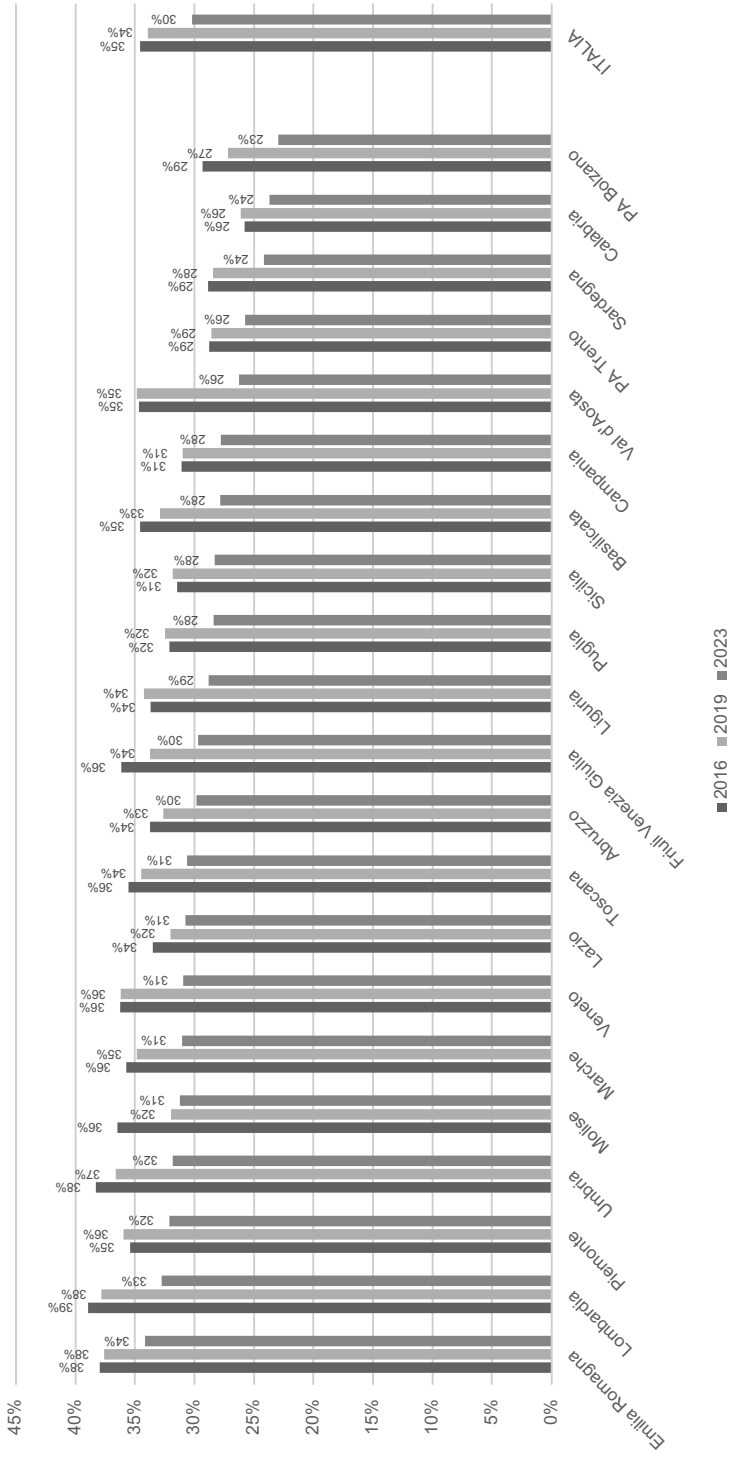
Infine, la Figura 3.11 restituisce un possibile rapporto tra *input* e *output* di sistema, con affondo sui singoli contesti regionali. In particolare, la Figura mette in relazione il valore delle prestazioni di secondo livello (ricoveri e specialistica ambulatoriale, valorizzati secondo le tariffe vigenti a livello nazionale) erogate nei diversi contesti regionali e i valori di spesa sostenuti. In questo caso, l'anno di riferimento è il 2023, ultimo dato utile per la specialistica. La Figura, sebbene mostri una misura macroscopica e suscettibile di diversi ulteriori approfondimenti specifici, rappresenta una proxy di produttività del SSN e degli SSR (o quantomeno impiega la logica prestazionale con cui oggi il SSN si definisce per fornire una rappresentazione delle modalità d'impiego delle risorse). A livello nazionale, il valore delle prestazioni di secondo livello 2023 rispetto alla spesa complessivamente sostenuta nello stesso anno è pari al 30%, in calo rispetto al 2019 (era 35%). Il calo del valore dell'indicatore è diffuso in tutti gli SSR, che tuttavia registrano dei valori molto diversi tra loro: dal 33-34% di Emilia Romagna e Lombardia al 23-24% di PA Bolzano, Calabria e Sardegna, denotando dei differenziali di produttività registrata molto significativi.

3.5 Equilibri e politiche di bilancio a supporto delle strategie in nove contesti regionali

L'incremento del disavanzo complessivo registrato nel 2024 (752 milioni di Euro, a fronte dei 55 del 2023 e dei 285 milioni del 2022), rispetto al finanziamento complessivo continua a rappresentare una quota contenuta, pari allo 0,5%. Tuttavia, tale aumento spinge a interrogarsi sulla tenuta prospettica del SSN e sulla sostenibilità dei diversi modelli regionali. I dati dell'ultimo biennio, infatti, rappresentano un punto di rottura rispetto al trend degli anni pre-pandemia e degli anni colpiti da Covid-19 e segnalano ulteriormente la necessità di porsi seriamente il tema delle traiettorie programmatorie percorribili dal SSN a fronte di una crescente divaricazione tra risorse e bisogni di salute espressi da una popolazione sempre più anziana.

In questo quadro, il paragrafo propone un approfondimento su nove regioni esemplificative di modelli, contesti territoriali e storia pregressa differenti, selezionati sulla base della popolazione (almeno 3 milioni di residenti): Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia. Il campione nel suo complesso rappresenta circa l'80% della popola-

Figura 3.11 **Valore della produzione (ricoveri e specialistica) in relazione alla spesa sanitaria pubblica regionale Confronto 2016, 2019, 2023**



Fonte: elaborazioni OASI su Rapporto SDO (2025) e Ragioneria Generale dello Stato (2025).

zione nazionale. Prima di presentare i dati sono necessarie alcune precisazioni metodologiche che chiariscano l'approccio usato e le modalità di aggregazione dei dati, oltre che le differenze osservabili rispetto all'approccio implementato nelle analisi dei paragrafi precedenti.

I casi sono stati costruiti usando fonti molteplici. Si è lavorato in primis su fonti documentali, analizzando le delibere di assegnazione dei fondi regionali e quelle di approvazione dei bilanci consuntivi per gli anni 2023 e 2024. Sono stati quindi analizzati i Conti Economici (consuntivi) ex Modello Ministeriale 2019 per verificare le dinamiche evolutive dei SSR oggetto di analisi. Questa duplice vista ha consentito (i) di proporre alcune riflessioni sulle politiche regionali sviluppate o in corso di discussione per il contenimento degli eventuali disavanzi e (ii) di verificare o intercettare l'attivazione di processi riallocativi coerenti con l'evoluzione dei modelli di servizio. Applicando la tecnica dell'analisi di bilancio[31], infatti, sono stati riclassificati i dati di CE al fine di ottenere dei macro-aggregati significativi e rappresentativi delle dinamiche regionali e della coerenza con l'evoluzione dei modelli di servizio a partire da quanto stabilito nelle delibere regionali di assegnazione dei fondi. Più nello specifico, guardando al finanziamento, sono state considerate in forma aggregata le principali poste: (i) fondo sanitario, sia indistinto che vincolato, per valutare incrementi complessivi nell'andamento del finanziamento e catturarne simultaneamente sia le variazioni legate a dinamiche strutturali e fisiologiche di evoluzione del sistema, sia quelle legate a fenomeni congiunturali del periodo 2019-2024; (ii) risorse proprie regionali, per comprendere se e quanto le regioni abbiano investito risorse proprie aggiuntive per sostenere l'erogazione di servizi sanitari. Lato assorbimento di risorse, invece, la riclassificazione è stata sviluppata a partire dal modello proposto da Anessi Pessina e Sicilia (2009) e impiegato nell'edizione 2022 del Rapporto (Armeni *et al.*, 2022) che guarda alle componenti di costo per produzione interna e produzione esterna (o anche detta attività di committenza)[32]. Questo modello di rappresentazione è stato riadattato conservando la logica che guarda alle diverse modalità di produzione dei servizi, ma distinguendo i fattori produttivi rispetto alla loro dinamica di approvvigionamento (se sul mercato o meno) e alle modalità di impiego nell'erogazione di servizi. In particolare, la Tabella 3.12 offre una fotografia dell'impostazione dell'analisi qui proposta e dettaglia le poste contabili impiegate per ciascun aggregato. In particolare, in continuità con l'ultima edi-

[31] Per una trattazione della materia con specifico riferimento alle aziende sanitarie pubbliche si veda il Capitolo 15 del Rapporto OASI 2015, il Capitolo 17 del Rapporto OASI 2017, il Capitolo 13 del Rapporto OASI 2019.

[32] Nello specifico non sono state incluse nell'analisi le voci: B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), B.9.C) Altri oneri diversi di gestione, B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti, B.13) Variazione delle rimanenze.

Tabella 3.12 **Aree, categorie, componenti impiegate e poste contabili ex Modello Ministeriale CE 2019 impiegate nell'analisi**

Area	Categoria	Componente	Sotto-componente
Finanziamento / Ricavi		Energia	
		Risorse proprie regionali	
		Pay-back	Pay-back pharma
			Pay-back DM
Costi	Rischio di mercato	Energia	Riscaldamento
			Elettricità
			Altro (riscaldamento)
		Beni sanitari e non sanitari	Beni sanitari
			Beni non sanitari
		Servizi non sanitari*	Lavanderia
			Pulizia
			Mensa
			Altri servizi non sanitari
		Manutenzioni fabbricati, impianti e attrezzature	Fabbricati
			Impianti e macchinari
			Attrezzature sanitarie e scientifiche
		Godimento beni di terzi	Fitti passivi
			Noleggi
			Leasing e project financing
	Organizzazione dei servizi	Personale dipendente e assimilato	Rinnovo contratti collettivi
			Inserimenti a tempo indeterminato
			Inserimenti a tempo determinato
			Inserimenti altro
		Modelli di servizio territoriali	Socio-san a valenza sanitaria
			MMG
			Specialistica ambulatoriale
			Riabilitazione
			Psichiatria
		Servizi sanitari*	
		Farmaceutica	Servizi per farmaceutica
			Prodotti farmaceutici
			Rimanenze
			Altro

* al netto delle poste incluse in altre componenti dell'analisi

zione del Rapporto (), sono state organizzati due macro-aggregati: (i) "rischio di mercato", in quanto fattori produttivi direttamente collegati a modalità di approvvigionamento e a mercati le cui oscillazioni aumentano la variabilità inter-temporale del costo di acquisizione e della disponibilità di beni e servizi; (ii) "geografia dei servizi", che include invece categorie di costo e fattori produttivi la cui variabilità è collegata alle scelte di assetto interne ai singoli territori e alle modalità di configurazione ed erogazione dei diversi servizi

erogati. La lettura e interpretazione dei valori di questi aggregati è dinamica: non si concentra tanto sui valori assoluti negli esercizi considerati, quanto sugli scostamenti osservati negli archi temporali considerati nelle Tabelle e Figure che seguono.

L'analisi, i cui dati aggregati sono presentati nelle successive Tabella 3.13 e Tabella 3.14, mira ad analizzare la dinamica dei costi e la loro evoluzione negli anni, al fine di identificare quali siano i fattori produttivi che sono stati caratterizzati da maggiore oscillazione nel tempo. Si ipotizza, infatti, che questi siano indicativi dei trend di cambiamento che stanno attraversando i sistemi regionali, in termini di scelte produttive, di assetto dei servizi e di gestione delle risorse economiche ma anche conseguenza di dinamiche macro-economiche che colpiscono diversi settori dell'economia, come si discuterà di seguito.

Con riferimento ai trend macro-economici citati, è importante considerare che diverse crisi congiunturali hanno impattato negli ultimi anni sulla struttura dei costi delle Aziende e delle Regioni. Tra questi, si segnala l'incremento dei costi del personale, frutto dell'aumento degli organici in prima battuta per fronteggiare il periodo pandemico e delle successive misure per l'adeguamento delle condizioni contrattuali, e dei costi dei servizi territoriali, conseguente al rafforzamento dell'assistenza di prossimità indotto da PNRR e DM77. L'inflazione ha altresì comportato un significativo aumento del costo dell'energia nel corso del 2022, parzialmente riassorbita nel corso del 2023 e del 2024, e di beni sanitari e non sanitari e servizi non sanitari.

Durante il periodo 2019-2024, le voci di costo analizzate sono incrementate di quasi 23,0 mld a livello nazionale. I costi derivanti da determinanti a elevata esposizione a rischio di mercato sono aumentati di 5,2 mld (+29% nel periodo; CAGR pari al 5,2%), registrando un trend profondamente diverso rispetto a quello del periodo pre-pandemico (+0,9 mld, +5% tra 2017 e 2019; CAGR pari al 2,6%). Interessante notare come l'aumento del costo dell'energia registrato nel 2022 (+1,4 mld tra 2021 e 2022) sia stato parzialmente riassorbito nel corso del 2023 e del 2024 (-919mln), grazie al contenimento degli importi ascrivibili a utenze elettriche (-560mln) e riscaldamento (-334mln; -22%). In entrambi i casi, le riduzioni osservate sono perlopiù ascrivibili e proporzionali alla riduzione del prezzo di acquisizione della materia prima più che a fenomeni (auspicabili) di miglioramento del profilo di consumo delle aziende del SSN. Inoltre, il combinato disposto di emergenza pandemica e dinamica inflattiva ha investito anche gli acquisti di beni sanitari e non sanitari (+2,2mld tra 2019 e 2024; +28%) e servizi non sanitari (+1,6mld; +29%), per un totale di +3,6mld registrato tra 2019 e 2024 (+28,7%). Sui beni sembra aver inciso maggiormente la risposta alla pandemia (+1,5mld tra 2019 e 2020 – dato non riportato in Tabella), sebbene il livello dei costi sostenuti sia comunque rimasto elevato e ormai considerabile strutturale, sostenuto dall'aumento dei prezzi di acquisizione dei fattori produttivi e dall'aumento, soprattutto nel 2023, della produzione delle aziende.

Tabella 3.13 **La riclassificazione delle principali voci di costo dei SSR nell'ultimo biennio (2022-2024), nel periodo emergenziale (2019-2022) e pre-pandemico (2017-2019)**

ITALIA													
	Voci di costo	**2017**	**2019**	**2022**	**2024**	**Δ 2017-2019**	**Δ 2019-2022**	**Δ 2022-2024**	**Δ 2019-2024**	**CAGR 2017-2019**	**CAGR 2019-2022**	**CAGR 2022-2024**	**CAGR 2019-2024**
RISCHIO DI MERCATO	Energia	1.607	1.663	3.186	2.267	56	1.523	-919	604	1,7%	24,2%	-15,6%	6,4%
	Beni sanitari e non sanitari	7.382	7.861	9.243	10.072	479	1.382	829	2.212	3,2%	5,5%	4,4%	5,1%
	Servizi non sanitari	5.489	5.669	6.743	7.309	180	1.073	567	1.640	1,6%	5,9%	4,1%	5,2%
	Manutenzioni fabbricati, impianti e macchinari	1.837	1.933	2.156	2.344	96	223	189	411	2,6%	3,7%	4,3%	3,9%
	Godimento beni terzi	1.077	1.181	1.319	1.575	104	138	256	394	4,7%	3,8%	9,3%	5,9%
	Totale	**17.392**	**18.307**	**22.647**	**23.568**	**915**	**4.340**	**921**	**5.261**	**2,6%**	**7,3%**	**2,0%**	**5,2%**
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	Personale	37.592	38.566	42.574	45.493	975	4.007	2.919	6.926	1,3%	3,4%	3,4%	3,4%
	Modelli di servizio territoriali	20.627	21.541	22.735	24.388	914	1.194	1.653	2.847	2,2%	1,8%	3,6%	2,5%
	Farmaceutica	20.698	21.680	23.889	27.325	982	2.209	3.436	5.645	2,3%	3,3%	6,9%	4,7%
	Servizi sanitari	18.360	19.249	19.661	21.536	890	411	1.875	2.287	2,4%	0,7%	4,7%	2,3%
	Totale	**97.276**	**101.036**	**108.859**	**118.742**	**3.760**	**7.823**	**9.883**	**17.705**	**1,9%**	**2,5%**	**4,4%**	**3,3%**
TOTALE		**114.669**	**119.343**	**131.506**	**142.310**	**4.675**	**12.162**	**10.804**	**22.967**	**2,0%**	**3,3%**	**4,0%**	**3,6%**

Valori assoluti in milioni di euro e scostamenti relativi

Nota: Il CAGR (Compound Average Growth Rate) misura il tasso di crescita medio annuo. Per un periodo triennale il CAGR è pari a: (Valore ultimo anno/Valore primo anno)^(1/3)-1.

Fonte: Elaborazioni su CE regionale (codice "999"), Ministero della Salute (2025).

Tabella 3.14 **Incremento delle voci di ricavo e costo in selezionati SSR (2024 rispetto a 2023). Valori assoluti in milioni di euro**

			Piemonte	Lombardia	Veneto	ER	Toscana	Lazio	Puglia	Campania	Sicilia	Italia
RICAVI	Ordinari	Incremento FSN	401	1.009	253	339	332	591	272	589	510	**5.765**
	Straordinari	Payback farmaceutico	23	-214	-114	57	25	22	31	45	15	**-3**
	Risorse proprie regionali	Risorse aggiuntive da bilancio regionale	1	-1	-10	-46	38	0	14	0	0	**31**
	Totale		425	794	129	350	395	612	317	634	526	**5.793**
COSTI	RISCHIO DI MERCATO	Energia	2	-44	-33	-38	-6	-37	-19	3	-4	**-240**
		Beni sanitari e non sanitari	37	85	47	48	29	48	48	105	25	**570**
		Servizi non sanitari	27	44	-59	19	17	26	2	60	37	**241**
		Manutenzioni fabbricati, impianti e maccchinari	-7	14	7	29	-27	3	-7	18	10	**61**
		Godimento beni terzi	12	50	10	10	14	6	12	12	7	**163**
		Totale	71	149	-29	68	26	46	35	198	75	**795**
	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	Personale	238	200	166	168	134	21	125	305	223	**2.161**
		Rafforzamento servizi territoriali	55	246	79	78	71	119	72	27	107	**1.063**
		Farmaceutica	142	384	135	157	120	210	137	300	156	**2.114**
		Servizi sanitari	5	57	64	123	68	134	126	164	144	**1.187**
		Totale	440	888	444	526	393	483	460	797	631	**6.526**
	Totale		511	1.037	415	594	419	529	495	995	705	**7.320**

Fonte: Elaborazioni su CE regionale (codice "999"), Ministero della Salute (2025).

Anche i costi relativi alle manutenzioni ordinarie e al godimento di beni di terzi sono incrementati, rispettivamente di 394 e 411 mln rispetto al periodo pre-pandemico, a un ritmo di crescita annuo che ha visto un'accelerazione nell'ultimo biennio considerato (rispettivamente CAGR pari a +9,3% e +4,3%).

Passando all'area maggiormente collegata alla geografia dei servizi, si registra un incremento complessivo nel periodo 2019-2024 di 17,7mld (+18%), con un tasso medio annuo di crescita del 3,3%. L'ultimo biennio ha visto un aumento medio annuo più elevato dei precedenti periodi considerati (+4,4% a fronte di +1,9% del periodo 2017-2019 e +2,5% del periodo 2019-2022). I costi del personale rappresentano la voce più consistente, in aumento di 4,0 mld tra 2019 e 2022 e di ulteriori 2.9mld nell'ultimo biennio (medesimo tasso annuo di crescita annuo, +3,4%). Per fronteggiare la diffusione del virus i SSR hanno incrementato gli organici sospendendo le politiche di contenimento dei costi del personale in corso nella fase pre-pandemica, a cui si è aggiunta la successiva fase di rinnovo dei contratti in essere. Anche la componente di servizi territoriali registra un aumento significativo tra 2019 e 2024, pari a circa 2,8, di cui la maggior parte (1,6mld) tra 2023 e 2024. L'aumento osservato tra 2019 e 2024 è riconducibile al consistente aumento delle voci relative alle prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (+1.3mld; +23% nel periodo), alla specialistica ambulatoriale (+870mln; +14%) e all'assistenza primaria (+290mln; +4%). Si osservano poi due ulteriori trend tra 2019 e 2024: da un lato, si registra significativo incremento della componente farmaceutica (+3,4 mld nell'ultimo biennio, +6,9% annuo a fronte di +2,3% annuo del periodo pre-pandemico e un +3,3% annuo tra 2019 e 2022), che include sia la convenzionata che gli acquisti diretti; dall'altro, una nuova accelerazione nell'incremento della voce relativa ai servizi sanitari[33] (+1.9 mld nel periodo 2022-2024; +4,7% annuo).

In secondo luogo, sono stati analizzati gli incrementi delle principali voci di ricavi e costi registrati nel corso del 2024 rispetto all'anno precedente (Tabella 3.14), dando evidenza delle differenze interregionali registrate. In questo caso, oltre alle voci di costo considerate sinora, sono altresì stati analizzati il finanziamento ordinario e straordinario dell'esercizio e verificate le dinamiche di riassorbimento dei tratti eccezionali che avevano in precedenza caratterizzato il 2022 (es. costo dell'energia, payback farmaceutico). Con specifico riferimento al finanziamento, la componente ordinaria è costituita dal finanziamento indistinto e vincolato, mentre la componente straordinaria è rappresentata dalle risorse aggiuntive *una tantum* fornite dal livello nazionale e dalle risorse proprie regionali eventualmente impiegate dai SSR per il contenimento dei disequilibri registrati.

Nel 2024, l'incremento del finanziamento è stato complessivamente pari

[33] Si sottolinea nuovamente che la voce è da considerare al netto delle componenti già incluse nel framework utilizzato.

a circa 5,8 mld. L'aumento è derivante dall'incremento dei trasferimenti da Fondo Sanitario Nazionale e dalla continuità nelle risorse aggiuntive garantita dalle Regioni con propri fondi (per LEA ed extra-LEA – cfr Figura 3.10). Dall'altro lato, l'incremento dei costi è stato pari a circa 7,3 mld. I costi derivanti dall'esposizione al rischio di mercato sono cresciuti di circa 800mln, prevalentemente imputabili all'aumento dei costi per beni sanitari e non sanitari (+570mln) e dei servizi non sanitari (+241mln). Tra le voci di costo attribuite alla geografia dei servizi nella classificazione qui proposta sono invece incrementate di circa 7,3mld. L'entità di tale aumento è collegata a un importante accelerazione nell'aumento dei costi sostenuti per la farmaceutica (+2,1mld; era 1,3 mld tra 2023 e 2022) e per il personale (+2,1 mld; era +758 mln tra 2023 e 2022), a cui si accompagnano aumenti significativi anche rispetto al ricorso all'acquisto di servizi sanitari (+1,1 mld) e al rafforzamento dei servizi territoriali (+1,0 mld).

Guardando ai nove casi regionali, si denotano alcune differenze significative fra i SSR. Osservando i ricavi, la principale differenza riguarda le risorse proprie regionali. Da un lato, si registrano regioni che non hanno previsto alcuna modifica rispetto all'anno precedente (Campania, Sicilia e Lazio); dall'altro, ci sono regioni che hanno deciso di modificare rispetto all'esercizio precedente la raccolta di tali risorse, sulla base delle possibilità concesse dal bilancio regionale (es. Toscana, +38mln; Emilia Romagna, -46mln, più che compensate dall'aumento del payback di 57mln). D'altro canto, si osservano differenze significative anche nell'assorbimento di risorse. Con riferimento ai fattori produttivi maggiormente esposti al rischio di mercato si osserva, in termini assoluti, (i) un diverso grado di riassorbimento dei costi legati al consumo di energia (dai -44mln della Lombardia ai +3mln della Campania); (ii) una sostanziale differenza nell'evoluzione degli oneri sostenuti nell'acquisizione dei beni (dal +25mln della Sicilia al +105mln della Campania); (iii) incrementi generalizzati sui servizi non sanitari (ad eccezione del Veneto). Con riferimento, invece, ai fattori produttivi qui abbinati alla geografia dei servizi, le differenze tra 2024 e 2023 riguardano in maniera significativa e diffusa tutte le componenti considerate, seppur con intensità diverse nei diversi contesti regionali.

Anche dai dati 2024, dunque, emerge come alcune dinamiche siano ormai in fase di consolidamento con livelli di strutturalità significativi, in termini assoluti abbinabili potenzialmente a evoluzione dei bisogni e dei modelli di servizio emergenti (si pensi al rafforzamento del setting territoriale), che tuttavia non sono accompagnati da un riorientamento e un processo riallocativo deciso delle risorse (es. tra setting).

3.6 La prospettiva aziendale: alcuni indicatori su equilibrio economico, autonomia manageriale e produttività delle grandi aziende pubbliche a vocazione ospedaliera

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di analizzare le macro-voci di conto economico delle grandi aziende "a vocazione ospedaliera" del SSN, offrendo alcune evidenze, da un lato, sul loro equilibrio economico-reddituale, e dall'altro, sul loro grado di autonomia operativa, rigidità della struttura dei costi e produttività.

L'attenzione per le grandi aziende ospedaliere pubbliche è motivata dalla loro rilevanza per il sistema di offerta del SSN, ma anche per le dimensioni economico- finanziarie (cfr. *infra*), in grado di condizionare notevolmente l'equilibrio dei SSR di appartenenza. Una decina di anni fa, l'argomento era tra i più noti e dibattuti della sanità italiana: ad esempio, la Legge di Stabilità per il 2016 aveva previsto specifici piani di rientro per le aziende ospedaliere con significativi scostamenti[34] tra costi e ricavi. Il sopraggiungere del Covid-19 e la prevalente attenzione per il territorio indotta dal DM 77/22 hanno contribuito a diminuire la visibilità di questo tema, che si vuole qui riprendere sinteticamente alla luce dei dati di CE disponibili.

Il campione considerato è composto da 15 aziende sanitarie pubbliche. Esse rientrano in criteri che le qualificano ragionevolmente come "di grandi dimensioni" e "a vocazione ospedaliera" (d'ora in avanti, per semplicità, solo "grandi aziende ospedaliere").

- Si tratta di AO, AOU, IRCCS o ASST: il meccanismo di finanziamento principale, almeno teoricamente, è a tariffa per prestazione; non sono incluse aziende finanziate a quota capitaria.
- Gestiscono uno stabilimento ospedaliero di almeno 800 posti letto ospedalieri[35]. Non si tratta quindi necessariamente delle aziende con più posti letto in assoluto, ma tutte si misurano con le problematiche proprie dei più grandi *hub* ospedalieri: presenza, in un unico grande plesso, di un elevato numero di alte specialità, di un DEA di II livello, di flussi di mobilità attiva, di attività di formazione e ricerca più o meno sviluppate. Questo elemento dimensionale tende a rendere comparabile, tra le aziende del campione, la tipologia di attività svolta e la funzione ricoperta nel sistema regionale e oltre.
- Contabilizzano costi della produzione superiori a 500 milioni di Euro.

[34] Cfr. art 1, comma 524 e seguenti L. 208/15. Le regioni con uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% o pari ad almeno 10 milioni sono tenute a presentare un piano di rientro alla propria regione. Lo stesso in caso di "mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti".

[35] La fonte è il database open source dei PL ospedalieri del SSN per regione e disciplina, reso disponibile dal Ministero della Salute.

Le aziende del campione sono riportate in Figura 3.12. Sono rappresentate assieme ai dati di valore della produzione[36], che in quest'ambito può essere considerato come l'insieme delle risorse di cui dispone l'azienda per erogare i servizi, e di costo della produzione[37]. Sommando il valore della produzione delle 15 aziende si raggiunge un totale di 11,2 miliardi di Euro; sommando i costi della produzione, 11,3 miliardi, poco meno della spesa sanitaria di una grande regione come Veneto o Emilia-Romagna (cfr. *supra*).

In termini di profilo geografico, si può osservare che due terzi (10 su 15) delle aziende sono localizzate nelle regioni del Nord, di cui quattro in Lombardia, due in Veneto, due in Emilia-Romagna, una in Piemonte e una in Liguria. Segue il Centro con tre aziende, due in Toscana e una nel Lazio. Solo due aziende sono localizzate nel Sud continentale, una in Campania e una in Puglia, mentre nelle Isole non si conta nessuna Azienda che rientri nei criteri fissati. Il ridotto dimensionamento degli *hub* ospedalieri del Mezzogiorno si conferma come elemento critico ancora caratterizzante l'SSN.

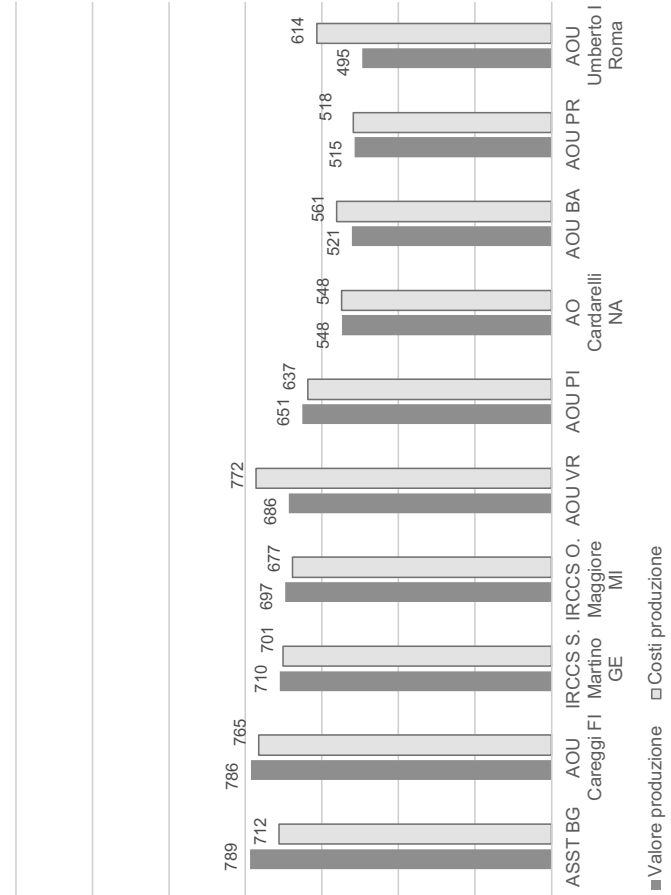
In termini di denominazione istituzionale, la maggioranza delle Aziende (10) sono Ospedaliero-Universitarie, talvolta con riconoscimento come IRCCS. Ad esse si può assimilare, per il profilo dell'attività prettamente ospedaliera e i legami con l'Università, la Fondazione IRCCS Policlinico di Milano – Ospedale Maggiore. Completano il quadro tre ASST lombarde che, pur avendo una forte centratura sull'ospedale *hub* di riferimento, gestiscono altre strutture ospedaliere o ambulatoriali distribuite sul territorio, e un ospedale di rilievo nazionale come l'AORN Cardarelli di Napoli.

Con riferimento alle macro-voci di CE osservate per l'anno 2024[38], lo scostamento tra valore e costi della produzione (assimilabile a un margine operativo netto) è positivo o nullo in 9 casi su 15; in due casi si rileva uno scostamento negativo entro il 2%; nei restanti quattro casi lo scostamento negativo è rilevante: AOU Padova, -6% (in assoluto, -50,9 mln €); AOU Bari, -8% (-39,9 mln €); AOU Verona, -13% (-85,5 mln€); Umberto I – Roma, -24% (-118,5 mln €). Sommando algebricamente i risultati operativi delle 15 aziende, si ottiene un margine negativo di 124 milioni di Euro, pari al -1% del valore della produzione aggregato.

Nei quattro contesti sopra riportati in cui il margine operativo è nettamente negativo, si rileva anche una perdita di rilievo, compresa tra -7% e -28% del valore della produzione (dato non riportato in figura), per un valore aggregato pari a -360 milioni di €. Tutte e quattro le aziende presentavano margini ampiamente negativi anche nel 2023[39]. Le altre aziende registrano un dato compreso

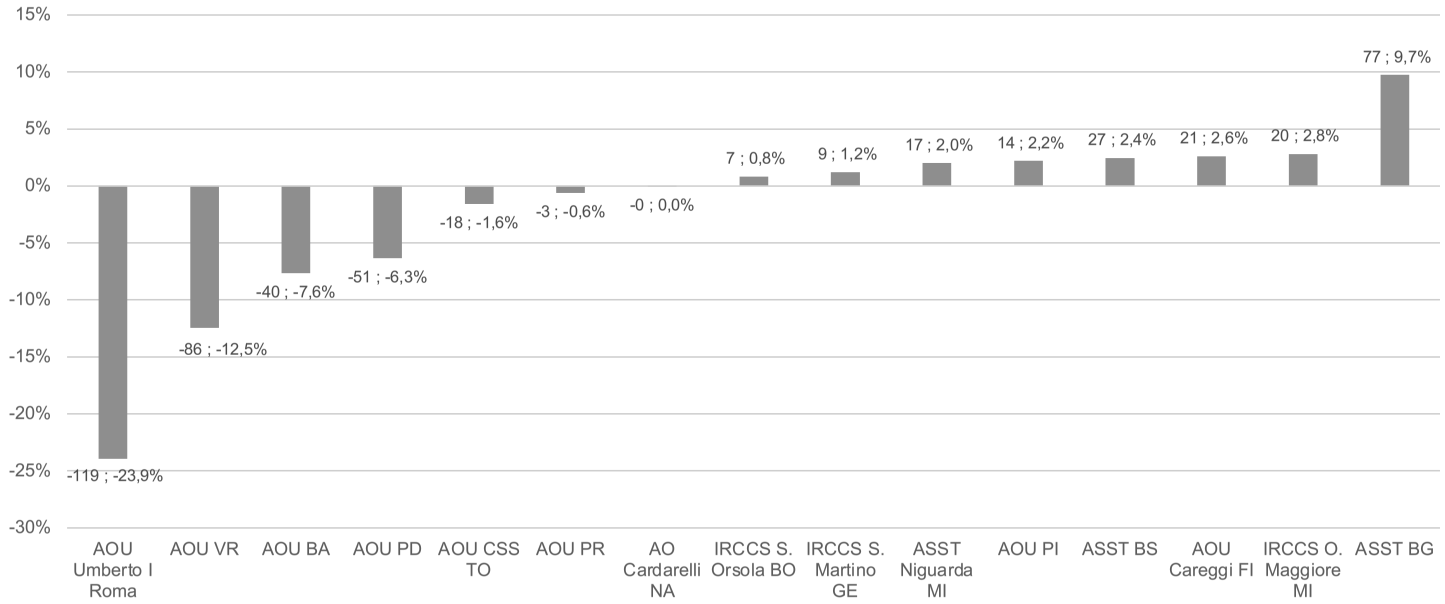
[36] Cfr. lettera A del prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN.
[37] Cfr. lettera B, *ibidem*.
[38] Per la CSS di Torino è stato possibile reperire solo il CE consuntivo 2023.
[39] AOU Bari -27,1 mln €, AOU Verona -59,7 mln €, AOU Padova -54,5 mln €, AOU umbertoI -140 mln €;

Figura 3.12 **Le grandi aziende ospedaliere pubbliche del SSN: valore della produzione e costi della produzione, mln€ (2024)**



Fonte: Elaborazioni su CE aziendali.

Figura 3.13 **Le grandi aziende ospedaliere pubbliche del SSN: scostamento percentuale tra valore della produzione e costi della produzione (2024)**



Nelle etichette è riportato anche il valore assoluto dello scostamento in mln€ arrotondato all'unità.

Fonte: Elaborazioni su CE aziendali.

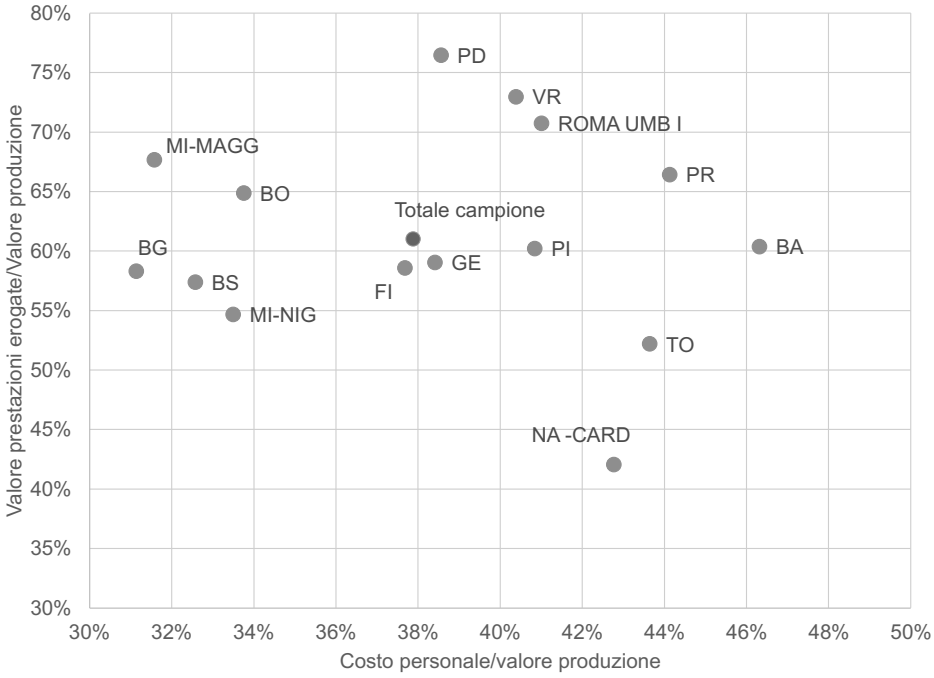
tra il pareggio e una perdita del 2%. Sommando algebricamente i risultati finali delle 15 aziende, si ottiene una perdita aggregata di 421 milioni di Euro, pari al -4% del valore della produzione aggregato. Le grandi aziende ospedaliere presentano quindi, nella maggioranza dei casi, un sostanziale equilibrio economico, salvo alcune realtà con situazioni indubbiamente più problematiche.

La rappresentazione sopra riportata può però essere arricchita da considerazioni sulla capacità effettiva delle aziende del campione di coprire i propri costi attraverso il valore delle prestazioni erogate. A questi si aggiunge di norma una quota, che si suppone minoritaria, di trasferimenti in conto esercizio, diretta a remunerare servizi "non tariffabili" come emergenza-urgenza, terapie intensive, o altro, oppure, di fatto, come semplice finanziamento corrente non vincolato. Tale capacità può essere verificata calcolando il quoziente tra i "ricavi" delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (d'ora innanzi "valore delle prestazioni erogate") e il valore della produzione totale (VP). Maggiore è il quoziente, minore è il grado di dipendenza dell'azienda dai trasferimenti in conto esercizio da parte della regione. Inoltre, si può completare la visuale con un indicatore della rigidità dei costi come l'incidenza del costo del personale sul valore della produzione Figura 3.14. Le grandi aziende ospedaliere pubbliche del SSN: incidenza % dei costi della personale sul valore della produzione (asse orizzontale) e incidenza % del valore delle prestazioni erogate sul valore della produzione (asse verticale), 2024 o ultimo disponibile (Figura 3.14).

Aggregando i valori di CE delle 15 aziende ("Totale campione" nel grafico), l'incidenza del costo del personale sul VP è pari al 38%, quella del valore delle prestazioni è pari al 61%. Emerge quindi uno scenario in cui i trasferimenti in conto esercizio sono in media rilevanti (quasi il 40%). In generale, le aziende che si avvicinano al settore in alto sulla sinistra del grafico, come Ospedale Maggiore di Milano e S. Orsola di Bologna, si caratterizzano per un buon grado di spazio di manovra manageriale: il costo del personale, notoriamente assimilabile ai costi fissi in ambito pubblico, è ridotto rispetto ai finanziamenti; tali finanziamenti derivano in percentuali significative da prestazioni erogate in contesti di mercato governato, riducendo la dipendenza dai trasferimenti regionali. All'opposto, le aziende più vicine al settore in basso a destra, come CSS di Torino e Cardarelli di Napoli, sono caratterizzate da elevate rigidità dei costi e forte dipendenza dai finanziamenti in conto esercizio dell'ente sovraordinato. Si segnala un elemento di rilievo: le aziende con i margini operativi più negativi, e le perdite più consistenti (cfr. *supra*), sono contraddistinte da un'elevata incidenza del valore delle prestazioni erogate e allo stesso tempo da costi del personale che raggiungono quote simili o più elevate rispetto al totale del campione. Viceversa, le ASST lombarde, che segnalano percentuali relativamente ridotte per entrambi i parametri, chiudono il bilancio tutte in pareggio.

Volendo cercare un *benchmark*, pur impreciso, al di fuori delle strutture pubbliche, si possono calcolare gli stessi indicatori per alcuni grandi privati

Figura 3.14 **Le grandi aziende ospedaliere pubbliche del SSN: incidenza % dei costi del personale sul valore della produzione (asse orizzontale) e incidenza % del valore delle prestazioni erogate sul valore della produzione (asse verticale), 2024 o ultimo disponibile**



Fonte: Elaborazioni su CE aziendali.

accreditati che rispettino i criteri di selezione del campione in quanto a PL ospedalieri dell'hub e valori del bilancio. L'Ospedale S. Raffaele Srl di Milano registra il 31% di costi del personale e l'84% dei ricavi da prestazioni sul valore della produzione; Humanitas Mirasole Spa il 24% dei costi del personale e il 94% dei ricavi da prestazioni; per la Fondazione Policlinico Gemelli le percentuali sono del 40% e del 78%.

3.7 Discussione e conclusioni

Nelle conclusioni al capitolo 3 del Rapporto OASI 2021 era stata proposta una riflessione circa la necessità di distinguere, nell'analisi dei dati di finanziamento e spesa sanitaria, gli effetti transitori della pandemia dalle misure strutturali. Più in generale, si faceva riferimento al fatto che la maggior parte delle misure visibili dai dati 2020 non erano da considerarsi destinate ad incrementare in

modo strutturale il finanziamento di sistema. Al netto dell'emergenza, infatti, già dai dati 2020 appariva evidente la tendenza a destinare la maggior parte del finanziamento incrementale a misure urgenti o comunque transitorie. Se questo fenomeno era comprensibile nel 2020, poiché gli effetti della pandemia avevano iniziato a manifestarsi a valle della programmazione, e, in maniera meno rassicurante, nel 2021, il 2022 aveva nuovamente scontato l'esigenza di rispondere con misure straordinarie a fattori emergenziali legati al contesto internazionale. Si trattava di un esercizio che assorbiva i fattori emergenziali recenti (pandemia, crisi energetica internazionale e ripresa dell'inflazione) nella consapevolezza che alcuni di questi sarebbero stati inesorabilmente destinati a perdurare e/o a strutturarsi nel medio-lungo periodo. Il 2023 iniziava a mostrare alcuni di questi tratti di consolidamento, sebbene ci fossero da superare alcuni degli strascichi collegati alle recenti dinamiche congiunturali sfavorevoli.

I dati 2024, meno influenzati da elementi contingenti e oramai prossimi alla conclusione del PNRR, aprono a questioni di medio-lungo periodo di carattere strutturale.

Il finanziamento da FSN per il 2024 è stato pari a 133 miliardi di euro con un incremento di 5 miliardi rispetto all'anno precedente. A questo finanziamento, si aggiungono ulteriori 10mld rappresentati da ricavi/entrate proprie, costi capitalizzati, rettifiche e utilizzo fondi e risorse proprie regionali. Dall'altro lato, la spesa pubblica complessiva è pari a circa 143,8 mld, registrando un aumento più che proporzionale rispetto all'aumento del finanziamento complessivo. Questi valori portano il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL a 6,6%, in aumento rispetto all'esercizio precedente (era 6,4%) e il disavanzo complessivo a circa 750mln (0,5% del finanziamento), in aumento rispetto al sostanziale pareggio del 2023. Quest'ultimo valore è fortemente mitigato dall'intervento regionale attraverso risorse proprie, che nel complesso vale 1,1mld, con circa 750mln impiegati a copertura di servizi LEA. Nei fatti il disavanzo rispetto al finanziamento centrale sarebbe pari a circa 1,5 mld. Questi diversi fenomeni tendono a evidenziare come l'intervento delle regioni sia cruciale per rispondere alla pressione sulla tenuta economica-finanziaria di alcuni SSR, sebbene le possibilità di stanziare risorse aggiuntive si stia riducendo nel tempo, anche considerando l'esiguità delle risorse proprie delle Regioni, tolta la componente sanitaria. Sono in particolare 9 gli SSR che presentano tensioni finanziarie potenzialmente significative. Tra queste, le principali risultano essere Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Piemonte. Queste regioni, che registrano i disavanzi più consistenti, hanno tra loro caratteristiche di assetto e configurazione dei servizi piuttosto diverse, oltre ad appartenere a differenti macro-aree del Paese. Così come nel 2023, non sembra dunque configurarsi una chiara correlazione tra quantità e intensità dei servizi offerti e risultati finanziari registrati nel 2024. In questa fase di nuova stabilizzazione, dunque, i disavanzi e gli avanzi registrati sembrano dipendere fortemente dalle politiche di auto-finan-

ziamento attivate e dalle conseguenti scelte allocative più o meno consapevoli promosse dagli SSR.

Rispetto al futuro alcune informazioni e indicazioni sono date nel Piano Strutturale di Bilancio 2025-29 e nei DDL Bilancio successivi, che prevedono un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno standard del SSN, sebbene non si osservino delle sostanziali modifiche rispetto al PIL programmatico. In questo senso, il lavoro di analisi qui presentato su costi e su fonti di finanziamento a livello di regioni ed aziende, rivela alcune dinamiche che verosimilmente caratterizzeranno i prossimi anni e che destano preoccupazione rispetto alla tenuta del SSN. Si tratta di uno scenario a cui è necessario abituarsi per ben impostare le politiche nazionali e locali. Da un lato i dati regionali mostrano come le diverse Regioni abbiano adottato in modo più o meno esplicito politiche di parziale auto-finanziamento regionale e come esse attuino dei meccanismi di compensazione interni volti a supplire alle differenze di equilibrio economico-finanziario tra aziende. Dall'altro lato, i dati aziendali e la riclassificazione proposta evidenziano il perdurare di criticità a livello di singole aziende, con una crescente sofferenza diffusa, dovuta all'aumento dei costi della produzione e ad una maggiore dipendenza da contributi da enti sovraordinati, che non trova una diretta corrispondenza nella quantità e nel mix di produzione e/o nelle metriche impiegate nella sua valorizzazione. Rapportando il valore delle prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale alla spesa sanitaria, a dati 2023, solo il 30% di quest'ultima si "trasforma" in erogato, in deciso calo rispetto al pre-pandemia (era il 35%, valore comunque modesto) e con forti differenze interregionali (dal 33-34% di Emilia-Romagna e Lombardia al 23-24% di PA Bolzano, Calabria e Sardegna). È chiaro come, da un lato, l'aumento dei costi di produzione sia significativo. Tra tutti, sono i fattori produttivi legati alla produzione diretta di servizi che mostrano un aumento particolarmente significativo, segnalando come il modello che vede le aziende del sistema protagoniste dell'erogazione viva una crisi rispetto al passato. Dall'altro, c'è da affrontare il tema del ruolo da assegnare alle modalità con cui il sistema tende a valorizzare la produzione (tariffe e politiche di rimborsabilità). Il capitolo, del resto, mostra come nelle grandi aziende pubbliche a vocazione ospedaliera l'incidenza dei ricavi da prestazioni si attesti in media al 61%, con variabilità significative tra le diverse realtà (tra 42% e 76%). Sebbene i dati mostrino come i singoli contesti regionali siano stati ancora in grado di reagire all'incremento delle distanza tra valore della produzione e costi con finanziamenti in conto esercizio, il rischio è che in futuro il disallineamento tra risultati di sistema e performance delle singole aziende diventi ancora più ampio e che il modello di finanziamento delle aziende si dimostri sempre più lontano dai loro reali meccanismi di funzionamento, con un continuo ricorso a meccanismi di ripiano e interventi "straordinari". Nei fatti il rischio è di cronicizzare la divergenza tra equilibrio

finanziario (garantito da finanziamento extra-esercizio non legato al valore della produzione, ma solo ai costi) ed equilibrio economico delle aziende, ovvero la loro reale produttività ed efficienza. Questo genera un gioco competitivo iniquo tra aziende (la maggiore o minore efficienza non viene sostanzialmente evidenziata) e rischia di minare alla base l'intera logica del processo di aziendalizzazione, basato su autonomia gestionale e responsabilità sui risultati.

È chiaro come si apra per il SSN e per gli SSR un'ulteriore stagione di profonda trasformazione, anche indotta dalle innovazioni sui modelli di servizi attese dall'impatto del PNRR e DM77. Dalla prospettiva regionale, esistono tre possibili logiche di governo attivabili per rivitalizzare gli impulsi all'aumento del valore prodotto dalle aziende, sintetizzate nella Figura 3.12.

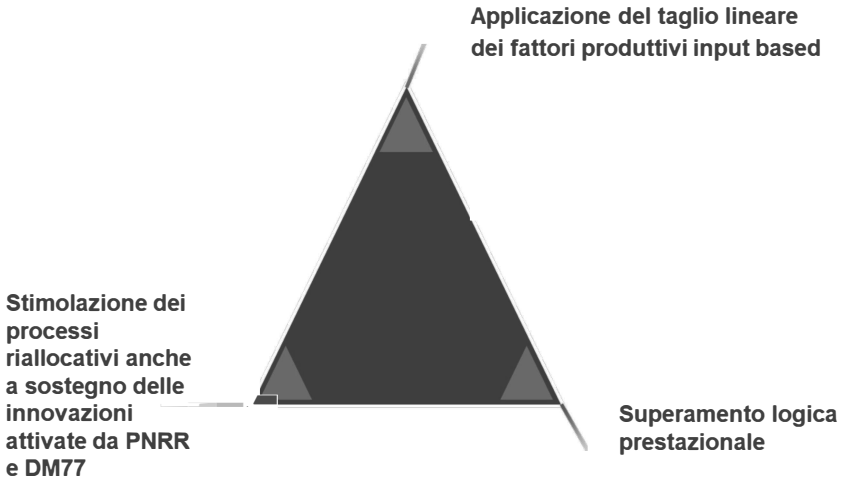
È fisiologico che i tre tensori non siano espliciti né esplicitati. Il rischio però è che non vi sia nemmeno consapevolezza sulla necessità di lavorare sul loro bilanciamento. Negli ultimi quindici anni, la principale leva attivata è stata quella del taglio lineare di specifici fattori produttivi (es. personale). Questo controllo *input based,* ancora oggi di fatto impiegato come principale meccanismo di risposta alle tensioni economico-finanziarie di sistema, garantisce l'allineamento tra spesa e risorse disponibili, ma non determina incentivi all'aumento dell'efficienza o alla trasformazione dei servizi. Questa logica di governo si scontra pertanto con i processi di innovazione attesi e indotti da PNRR e DM77 e rispondenti a un bisogno che cambia. Si tratta, nei fatti, di attivare processi che sostengano le innovazioni promosse dai nuovi dispositivi organizzativi, che necessitano una riallocazione di risorse tra setting (ospedale versus territorio), tra discipline (oncologia vs prevenzione), tra sanità e socio-sanitario, tra professioni. Controllare gli input è una prassi che le aziende conoscono e che gli stakeholder sono disponibili a concertare, mentre innovare tramite la riallocazione delle risorse rappresenta il processo sociale ed organizzativo più complesso nel settore dei servizi pubblici, perché l'allocazione storica rappresenta l'equilibrio di aspettative e poteri negoziato e accettato dai diversi portatori di interessi interni ed esterni. Per sostenere la logica di innovazione e riallocazione degli input, invece che di solo governo dei loro volumi, vi è una terza logica di governo disponibile, presentata in Figura, che consiste nel superare la prevalente logica prestazionale e approdare a meccanismi di presa in carico, correlata al prevalere di patologie croniche e bisogni socio-sanitari; coerentemente, è necessario attivare logiche di governo della domanda grazie a pacchetti prescrittivi chiusi per categoria di paziente preso in carico e definire chiare priorità di target e intensità assistenziali sostenibili.

Ovviamente le tre logiche di governo devono tra di loro convivere, con un gioco equilibrato tra i tensori che combini governo del totale delle spesa, riallocazione della stessa e innovazione delle logiche di servizio e di lavoro. Per un loro miglior equilibrio, occorre considerare che il rispetto dei volumi di input registra precisi incentivi e metriche, che sono ancora da sviluppare per le altre

due logiche di governo, fattore che rende difficile il superamento del primo tipo di leva. L'equilibrio tra i tre tensori può avvenire anche in modo implicito, garantendo spazio per ogni narrazione desiderata, se accompagnato da sufficiente consapevolezza tra i tecnici regolatori e il management delle aziende.

Riprendendo alcune delle riflessioni sviluppate nel capitolo, si sottolinea qui quanto il sistema di finanziamento per quota capitaria sia sufficientemente equo, ma quanto altresì esistano temi di performance più complessi e rilevanti, non catturabili da una metrica prestazionale, come la misurazione del tasso di copertura dei bisogni, il livello di appropriatezza delle cure, gli esiti intermedi e gli outcome di popolazione, l'intensità assistenziale media garantita e lo sviluppo di competenze cliniche, assistenziali e manageriali che un sistema sta costruendo per il futuro. Il superamento della logica prestazionale a favore di una logica a pacchetto di presa in carico rappresenta un'operazione complessa in un sistema poco abituato a muoversi in ottica trasversale, ma necessaria per promuovere l'organizzazione delle interdipendenze esistenti tra i diversi attori e iniziare a misurare alcune delle dimensioni rilevanti appena citate. Per ricomporre i sistemi di convenienza di ciascuno di essi, un elemento rilevante è rappresentato dalla capacità di esplicitare il ruolo da assegnare ai sistemi tariffari, avendo la forza di sottolinearne la differenza per i soggetti pubblici e per quelli privati accreditati (ad oggi segnaletici per i primi, decisivi per l'equilibrio economico-finanziario per i secondi), accompagnando la leva tariffaria con l'attivazione di meccanismi di *knowledge transfer* e *community building*

Figura 3.15 **Le possibili strategie regionali per il contenimento della tensione economico-finanziaria e il sostegno ai processi di innovazione e di trasformazione dei servizi**



Fonte: elaborazione degli autori

diffusi che decongestionino le responsabilità decisionali che afferiscono al top management e le distribuiscano in modo ragionato su livelli aziendali intermedi che limitino la contendibilità professionale e possano produrre integrazione nel repertorio di snodi intra ed extra-organizzativi esistenti a livello aziendale, specialmente in una fase in cui il terzo pilastro si affaccia come interlocutore crescentemente solido e complementare.

In conclusione, se fino al periodo pre-pandemico si osservava una condizione di sostanziale disallineamento tra quanto osservato a livello aggregato e a livello locale (da un lato, l'equilibrio complessivo del SSN, osservato attraverso gli aggregati regionali e nazionali, dall'altro la difficoltà crescente delle aziende sanitarie a raggiungere l'equilibrio economico), più di recente gli interventi di riprogettazione e riorganizzazione dei sistemi sanitari regionali sollevano alcuni interrogativi sostanziali per la tenuta del SSN.

In primo luogo, è opportuno interrogarsi se e quali sistemi sanitari detengano il capitale istituzionale necessario per promuovere un profondo cambiamento nei modelli di servizio. L'attuale stagione di investimenti nel settore (es. PNRR), come si è già detto, non è accompagnata da un'espansione della spesa corrente, richiedendo di attivare un intenso processo riallocativo di risorse interno ai SSR. Il disegno di innovativi modelli di assistenza e la digitalizzazione dei servizi richiedono sofisticate competenze gestionali volte a rompere la *path dependency* attraverso processi di *change management*, così come un elevato rapporto di fiducia tra gli stakeholder interni ed esterni alle aziende.

In secondo luogo, è opportuno domandarsi quali possano essere i "luoghi" e i "livelli" dell'innovazione, ossia quali territori, attori (livello regionale, aziende sanitarie, distretti) e figure professionali (top o middle management, professionisti sanitari) siano in grado di guidare e diffondere efficaci processi di cambiamento. Questo implica lavorare su meccanismi di impulso e di incentivazione che realmente accompagnino i processi decisionali del livello istituzionale che riterremo più adatto ad essere imprenditore del cambiamento.

In terzo luogo, dobbiamo riflettere su quale metrica serva oggi al SSN per meglio evidenziare le criticità e la capacità del loro superamento: se si considerano gli aumenti costanti e significativi associati ad alcuni fattori produttivi collegati alla geografia dei servizi (es. farmaceutica), è chiaro che lavorare linearmente per input non possa consentire di conseguire risultati significativi sul fronte del bilanciamento tra livelli di servizio e tenuta dei conti. Spostare l'attenzione dal tema della produzione ("quanto generalizzato") a quella dei consumi ("cosa e per chi") può rappresentare un primo passaggio concettuale per stimolare processi riallocativi che sostengano la coerenza tra domanda di salute e configurazione dei modelli di offerta. Mappare per cittadini presi in carico invece che per prestazioni determina una ulteriore modifica cognitiva. Concettualizzare e monitorare le priorità di sistema rappresenta un cambio decisivo nella misura di ciò che è rilevante.

Appendice

Tabella 3.18 **Aree, categorie, componenti impiegate e poste contabili ex Modello Ministeriale CE 2019 impiegate nell'analisi**

Area	Categoria	Componente	Sotto-componente	Poste di riferimento/modalità di calcolo
Finanziamento / Ricavi		**Energia**	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse***
				AA0020 - A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
				AA0050 - A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
		Risorse proprie regionali	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
				AA0080 - A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
				AA0090 - A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA
		Pay-back	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
			Pay-back pharma	AA0890 - A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per pay back
				AA0900 - A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
				AA0910 - A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
				AA0920 - A.5.E.1,3) Ulteriore pay-back
			Pay-back DM	AA0921 - A.5.E.2) Rimborso per Pay-back sui dispositivi medici
Costi	Rischio di mercato	**Energia**	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
			Riscaldamento	BA1610 - B.2.B.1.4) Riscaldamento
			Elettricità	BA1660 - B.2.B.1.9) Elettricità
			Altro (riscaldamento)	BA1670 - B.2.B.1.10) Altre utenze
		Beni sanitari e non sanitari	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse***
			Beni sanitari	BA0020 - B.1.A) Acquisti di beni sanitari
			Beni non sanitari	BA0310 - B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
		Servizi non sanitari*	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse***
			Lavanderia	BA1580 - B.2.B.1.1) Lavanderia
			Pulizia	BA1590 - B.2.B.1.2) Pulizia
			Mensa	BA1600 - B.2.B.1.3) Mensa
			Altri servizi non sanitari	BA1570 - B.2.B.1) Servizi non sanitari
		Manutenzioni fabbricati, impianti e attrezzature	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
			Fabbricati	BA1920 - B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
			Impianti e macchinari	BA1930 - B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
			Attrezzature sanitarie e scientifiche	BA1940 - B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche

Area	Categoria	Componente	Sotto-componente	Poste di riferimento/modalità di calcolo
Costi	Rischio di mercato	Godimento beni di terzi	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
			Fitti passivi	BA2000 - B.4.A) Fitti passivi
			Noleggi	BA2010 - B.4.B) Canoni di noleggio
			Leasing e project financing	BA2040 - B.4.C) Canoni di leasing
				BA2061 - B.4.D) Canoni di project financing
			Da enti SSR	BA2070 - B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Costi	Organizzazione dei servizi	Personale dipendente e assimilato	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
			Rinnovo contratti collettivi	Totale sotto-componente
				BA2860 - B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
				BA2870 - B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
				BA2880 - B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
			Inserimenti a tempo indeterminato	Totale sotto-componente
				BA2120 - B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
				BA2160 - B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
				BA2200 - B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
				BA2250 - B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
				BA2290 - B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
				BA2340 - B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
			Inserimenti a tempo indeterminato	BA2380 - B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
				BA2430 - B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
				BA2470 - B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
			Inserimenti a tempo determinato	Totale sotto-componente
				BA2130 - B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
				BA2170 - B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
				BA2210 - B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
				BA2260 - B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
				BA2300 - B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
				BA2350 - B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
				BA2390 - B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato

Area	Categoria	Componente	Sotto-componente	Poste di riferimento/modalità di calcolo
Costi	Organizzazione dei servizi	Personale dipendente e assimilato	Inserimenti a tempo determinato	BA2440 - B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
				BA2480 - B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
			Inserimenti altro	Totale sotto-componente
				BA2140 - B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
				BA2180 - B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
				BA2220 - B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
				BA2270 - B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
				BA2310 - B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
				BA2360 - B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
				BA2400 - B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
				BA2450 - B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
				BA2490 - B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
				BA1200 - B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
				BA1420 - B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
			Inserimenti altro	BA1810 - B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
				BA1430 - B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
				BA1830 - B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
				YA0020 - Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
				YA0030 - Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
		Modelli di servizio territoriali	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
			Socio-san a valenza sanitaria	BA1140 - B.2.A.12) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
			MMG	Totale sotto-componente
				BA0410 - B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
				BA2840 - B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

Area	Categoria	Componente	Sotto-componente	Poste di riferimento/modalità di calcolo
Costi	Organizzazione dei servizi		Specialistica ambulatoriale	**Somma delle poste incluse**
				BA0530 - B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
				BA2850 - B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
				BA1220 - B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica
				YA0040 - Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
			Riabilitazione	BA0640 - B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
			Psichiatria	BA0900 - B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
		Servizi sanitari*	**Totale componente**	**BA0400 - B.2.A) Acquisti servizi sanitari***
		Farmaceutica	**Totale componente**	**Somma delle poste incluse**
			Servizi per farmaceutica	BA0490 - B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
			Prodotti farmaceutici	BA0030 - B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
			Rimanenze	BA2671 - B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
			Altro	BA0960 - B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

Bibliografia

Anessi Pessina E. (2005). L'equilibrio economico dei SSR e delle loro aziende nel biennio 2001-2002, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di), *L'aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2005*, Milano, EGEA.

Anessi Pessina E., Sicilia F., (2009). L'equilibrio economico dei Servizi Sanitari Regionali e delle loro aziende, E. Cantù (a cura di), *L'aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2009*, Milano, EGEA.

Armeni P., Borsoi L., Notarnicola E., Rota S., (2022). La spesa sanitaria: composizione ed evoluzione nella prospettiva nazionale, regionale ed aziendale, in CERGAS *Rapporto OASI 2022*, Milano, EGEA.

Armeni P. (2009). La spesa sanitaria: composizione ed evoluzione, in E. Cantù (a cura di), *L'aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2009*, Milano, EGEA.

Armeni P., Bertolani A., Borsoi L. e Costa F. (2020). La spesa sanitaria: composizione ed evoluzione, in CERGAS – Bocconi (a cura di), *L'aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2020*, Milano, EGEA.

Armeni P., Bertolani A., Costa F., Otto M., Jommi C (2018). L'acquisto di farmaci in Italia: l'effetto di approcci selettivi, in CERGAS – Bocconi (a cura di), *L'aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2018*, Milano, EGEA.

Corte dei conti (2025), *La sanità in cammino per il cambiamento, Sezioni riunite in sede di controllo, Quaderni del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica*, Quaderno n. 4, settembre.

Del Vecchio M. (2012). Settore, sistema e azienda: logiche di governance in sanità, Milano, EGEA.

Delibera n. 33/2023. Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (GU Serie Generale n.9 del 12-01-2024).

International Monetary Fund (2024). World Economic Outlook (April 2024). Disponbile a: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/April (ultimo accesso: 16 luglio 2024).

Intesa, ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2023 (Rep. atti n. 262/CSR del 9 novembre 2023)

ISTAT (2024). I.Stat (database). Disponibile a: http://dati.istat.it/ (ultimo accesso: 16 luglio 2024).

Jommi C. e Lecci F. (2005). La spesa sanitaria: composizione ed evoluzione, in E. Anessi Pessina, E. Cantù (a cura di), *L'aziendalizzazione della sanità in Italia: Rapporto OASI 2005*, Milano, EGEA.

MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato (2024), Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto n. 11, Roma.

Merlino L.G. e Ricci A. (2025), *Liste d'attesa, livelli di produttività e trend della specialistica ambulatoriale nel SSN del post-Covid*, Mecosan, 133, in corso di pubblicazione.

OECD (2024). OECD Data Explorer: Health expenditure and financing. OECD Health Statistics (database). Disponibile a: https://data-explorer.oecd.org (ultimo accesso: 16 luglio 2024).

Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) (2025), *Rapporto sulla politica di bilancio 2025*, Roma, giugno.

van Doorslaer E., Masseria C. and the OECD Health Equity Research Group Members (2004). Income-Related Inequality in the Use of Medical Care in 21 OECD Countries. OECD Health Working Paper No. 14.